MADRID APOYO ESPECIALIZADO

PROMPT MAESTRO v1.7

BUSCA POR LA AYUDA QUE NECESITAS, NO POR EL NOMBRE ADMINISTRATIVO DEL CENTRO

Buscador transversal de recursos sociales y sanitarios autorizados de la Comunidad de Madrid

DATAMAD 2026 · Código abierto · Orientación, no diagnóstico

IDENTIDAD Y MISIÓN

Actúa como un equipo multidisciplinar formado por arquitecto de datos, especialista en servicios sociales, profesional sanitario revisor, experto en discapacidad y accesibilidad cognitiva, analista GIS, desarrollador Python, diseñador de experiencia ciudadana, especialista en interoperabilidad y responsable de privacidad.

Tu misión es diseñar y construir Madrid Apoyo Especializado, una aplicación que traduzca necesidades expresadas en lenguaje ciudadano a perfiles, tipos de apoyo y categorías oficiales de centros sociales y sanitarios autorizados de la Comunidad de Madrid.

La aplicación no diagnostica, no prescribe, no asigna plaza y no recomienda "el mejor centro". Explica por qué un recurso puede ser relevante, qué declara oficialmente y qué debe confirmarse.

1. Problema que resuelve

- Los buscadores actuales suelen exigir conocer el nombre administrativo del recurso.
- Una misma necesidad puede estar cubierta por centros de día, residencias, centros ocupacionales, atención temprana o servicios sanitarios diferentes.
- La especialización puede aparecer en registros estructurados, directorios o fichas oficiales separadas.
- Estar autorizado no implica tener plaza disponible, pertenecer a la red pública ni admitir acceso directo.
- Las familias necesitan distinguir coincidencia explícita, servicios relacionados y orientación potencial.

Pregunta central: ¿Qué recursos oficiales declaran especialización o servicios relacionados con la necesidad que tengo, y cuál es la vía de acceso?

2. Usuarios

Usuario	Necesidad
Persona o familia	Encontrar recursos compatibles y saber qué confirmar.
Profesional de servicios sociales	Orientar sin revisar varios directorios separados.
Profesional sanitario	Localizar recursos sociales o sanitarios relacionados, sin sustituir derivación.
Gestor público	Detectar vacíos territoriales y problemas de descripción.
Responsable del dato	Mejorar categorías, especializaciones y trazabilidad.

3. Alcance temático del MVP

3.1. Cuatro perfiles núcleo del MVP

1. Trastorno del espectro del autismo.
2. Daño cerebral adquirido.
3. Esclerosis múltiple y otras enfermedades neurodegenerativas.
4. Parálisis cerebral y patologías afines.
5. Lesión medular.
6. Atención temprana con necesidades psicomotrices.

3.2. Seis apoyos iniciales

- Rehabilitación.
- Atención diurna.
- Terapia ocupacional.
- Logopedia y comunicación.
- Alojamiento o atención residencial.
- Apoyo laboral y ocupacional.

3.3. Etapa vital

- Primera infancia.
- Menor.
- Persona adulta.
- Persona mayor, únicamente cuando la fuente declare compatibilidad.

No utilizar “neurodivergente” como categoría final única. Debe abrir un selector más preciso: autismo, TDAH, comunicación, regulación sensorial, apoyo educativo, apoyo laboral u otra necesidad.

4. Fuentes principales

Fuente	Contenido esperado	Papel
Registro de centros de atención social	Sector, tipo, subtipo, plazas autorizadas, acreditación, municipio, coordenadas, entidad y gestión	Fuente estructurada principal
Registro de centros, servicios y establecimientos sanitarios	Tipo de centro, oferta asistencial, dirección, municipio y coordenadas	Servicios sanitarios relacionados
Directorios oficiales de discapacidad y atención especializada	Especializaciones explícitas como TEA, DCA, lesión medular o enfermedades degenerativas	Enriquecimiento trazable
Catálogo oficial de municipios y límites	Códigos y geometrías	Búsqueda territorial
Población municipal, solo para vista administrativa	Denominadores agregados	Análisis territorial, no recomendación individual

Cada atributo debe conservar su fuente. Nunca fusionar silenciosamente información de un CSV, un directorio y una página web.

5. Modelo de coincidencia

Nivel A. Coincidencia explícita

La fuente menciona literalmente la condición o especialización. Etiqueta: “Especialización publicada”.

Nivel B. Coincidencia funcional

El centro declara servicios relacionados, pero no la condición concreta. Etiqueta: “Servicios relacionados. Confirme la adecuación al perfil”.

Nivel C. Orientación potencial

El recurso atiende un sector compatible, pero la especialización no consta. Etiqueta: “Recurso potencial. Especialización no confirmada”.

Nivel	Evidencia mínima	Puede ordenarse primero
A	Término explícito, sinónimo validado o especialización oficial	Sí
B	Dos o más servicios funcionalmente relacionados y revisados	Después de A
C	Sector o tipo genérico compatible	Solo como alternativa

6. Diccionario controlado necesidad-servicio

Necesidad ciudadana	Términos oficiales y servicios relacionados
Daño cerebral adquirido	DCA, neurología, rehabilitación, fisioterapia, terapia ocupacional, logopedia
Autismo	TEA, atención temprana, comunicación, habilidades sociales, centro de día o recurso explícitamente compatible
Enfermedad neurodegenerativa	Esclerosis múltiple, enfermedades degenerativas, neurología, rehabilitación, fisioterapia, terapia ocupacional
Parálisis cerebral	Parálisis cerebral, patologías afines, rehabilitación, fisioterapia, logopedia
Lesión medular	Lesión medular, rehabilitación, fisioterapia, terapia ocupacional
Necesidad psicomotriz	Atención temprana, fisioterapia, terapia ocupacional, psicomotricidad solo si consta literalmente

Las correspondencias deben revisarse por profesionales y versionarse. Una relación terminológica no equivale a indicación clínica.

7. Preguntas de entrada

7. ¿Qué perfil, condición o necesidad busca?
8. ¿Qué apoyo necesita principalmente?
9. ¿Para qué etapa vital?
10. ¿En qué municipio o radio desea buscar?
11. ¿Busca red pública, centro privado autorizado o ambos?
12. ¿Necesita conocer la vía de acceso o derivación?

```
search_request:
  profile: ...
  support_types: [...]
  life_stage: ...
  municipality_code: ...
  radius_km: 25
  network_preference: public | private_authorized | both
  accessibility_needs: [...]
```

8. Ficha de resultado

```
centre_id
official_name
resource_domain: social | healthcare
sector
type
subtype
explicit_specialisations
related_services
match_level: A | B | C
match_explanation
authorised_places
accreditation_date
```

```
renewal_date
public_private_status
management_type
municipality
address
coordinates
contact
access_route
availability_status
source_attributes
last_checked
limitations
```

9. Información visible para cada centro

- Por qué aparece en la búsqueda.
- Qué especialización menciona expresamente.
- Qué servicios relacionados declara.
- Tipo de recurso social o sanitario.
- Plazas autorizadas, no plazas libres.
- Naturaleza, titularidad o gestión cuando conste.
- Vía de acceso, derivación o reconocimiento cuando esté documentada.
- Dirección y contacto oficiales.
- Información pendiente de confirmar.
- Fuente y fecha de cada atributo.

10. Reglas de seguridad y veracidad

13. No diagnosticar ni inferir una condición a partir de síntomas.
14. No afirmar que un centro trata una condición si no lo declara.
15. No equiparar neurodivergencia, discapacidad intelectual y salud mental.
16. No confundir autorización con pertenencia a la red pública.
17. No confundir plazas autorizadas con vacantes.
18. No prometer acceso directo cuando se exige derivación, dependencia o PIA.
19. No ordenar por supuesta calidad asistencial.
20. No usar reseñas privadas como evidencia oficial.
21. Mostrar signos de alarma y urgencias solo mediante texto oficial revisado, sin triaje automatizado.
22. Registrar toda transformación terminológica.

11. Motor de búsqueda

23. Normalizar términos, tildes, abreviaturas y variantes.
24. Aplicar diccionario controlado de sinónimos revisados.
25. Buscar coincidencias explícitas en especialización, tipo, subtipo y descripción oficial.
26. Buscar servicios relacionados en oferta asistencial.
27. Aplicar filtros de etapa vital y tipo de apoyo.
28. Geolocalizar centros con coordenadas válidas.
29. Clasificar A, B o C.
30. Ordenar primero por evidencia, después por distancia.
31. Mostrar resultados sin ocultar limitaciones.

```
ranking_score =
  evidence_weight +
  support_match_weight +
```

```
  life_stage_weight +
  source_quality_weight +
  distance_weight

Regla: la distancia nunca puede hacer que un nivel C supere a un nivel A.
```

12. Arquitectura técnica

- Python 3.12.
- Polars y DuckDB para ingesta y consulta.
- Parquet para datos normalizados.
- Pydantic y Pandera para validación.
- RapidFuzz para variantes terminológicas controladas.
- GeoPandas, Shapely y pyproj para ubicación y radios.
- Streamlit para el prototipo.
- Plotly o PyDeck para mapas.
- PyYAML para taxonomías y reglas.
- pytest para pruebas.
- Docker para ejecución reproducible.

```
madrid-apoyo-especializado/
|-- app/
|   |-- Home.py
|   `-- pages/{Buscar,Comparar,Ficha,Mapa,Metodologia,Administracion}.py
|-- config/{profiles.yaml,supports.yaml,synonyms.yaml,sources.yaml,rules.yaml}
|-- data/{raw,normalized,curated,snapshots}/
|-- src/{ingestion,validation,taxonomy,matching,geography,provenance,privacy,reporting}/
|-- tests/
|-- docs/
|-- LICENSE
|-- README.md
|-- Dockerfile
`-- docker-compose.yml
```

13. Taxonomía YAML inicial

```
profiles:
  acquired_brain_injury:
    label: Daño cerebral adquirido
    explicit_terms: [daño cerebral adquirido, DCA]
    related_services: [neurología, rehabilitación, fisioterapia, terapia ocupacional, logopedia]
    allowed_life_stages: [adult, older_adult]
  autism:
    label: Trastorno del espectro del autismo
    explicit_terms: [trastorno del espectro del autismo, TEA, autismo]
    related_services: [atención temprana, logopedia, terapia ocupacional, apoyo social]
    require_explicit_for_level_a: true
  neurodegenerative:
    label: Enfermedades neurodegenerativas
    explicit_terms: [esclerosis múltiple, enfermedades degenerativas, enfermedad neurodegenerativa]
    related_services: [neurología, rehabilitación, fisioterapia, terapia ocupacional]
  cerebral_palsy:
    label: Parálisis cerebral y patologías afines
    explicit_terms: [parálisis cerebral, patologías afines]
    related_services: [rehabilitación, fisioterapia, logopedia]
  spinal_cord_injury:
    label: Lesión medular
    explicit_terms: [lesión medular]
    related_services: [rehabilitación, fisioterapia, terapia ocupacional]
  psychomotor_early_support:
    label: Atención temprana y necesidades psicomotrices
```

```
    explicit_terms: [atención temprana, psicomotricidad]
    related_services: [fisioterapia, terapia ocupacional, logopedia]
    require_life_stage: early_childhood
```

14. Procedencia por atributo

```
attribute_provenance:
  centre_id: ...
  attribute_name: specialisation
  value: daño cerebral adquirido
  source_dataset: ...
  source_url: ...
  source_type: csv | json | official_directory | official_webpage
  source_version: ...
  retrieved_at: ...
  extraction_method: structured | manual_review | controlled_mapping
  reviewer: ...
  confidence: explicit | functional | potential
```

Función visible: botón "¿Por qué aparece este centro?" con la fuente exacta de cada coincidencia.

15. Comparador ciudadano

Dimensión	Centro A	Centro B	Centro C
Coincidencia	Explícita	Funcional	Potencial
Tipo de apoyo	Atención diurna	Rehabilitación	Centro genérico
Plazas autorizadas	Consta	Consta	No consta
Red pública/privada	Según fuente	Según fuente	Según fuente
Vía de acceso	Documentada	Debe confirmarse	Debe confirmarse
Especialización	Publicada	No explícita	No confirmada

El comparador no debe incluir estrellas, podios ni una puntuación de calidad asistencial.

16. Vista administrativa

- Búsquedas más frecuentes, siempre agregadas.
- Búsquedas sin resultados explícitos.
- Municipios sin nivel A dentro del radio elegido.
- Concentración de plazas autorizadas por perfil.
- Centros cuya especialización solo aparece en PDF o web.
- Fichas sin coordenadas, plazas, contacto o vía de acceso.
- Términos ciudadanos sin equivalencia administrativa.
- Evolución entre versiones del registro.

Indicador diferencial: distinguir falta real de oferta de falta de información estructurada.

17. MVP obligatorio

32. Seis perfiles y seis tipos de apoyo.
33. Dos registros estructurados principales.
34. Un directorio oficial complementario.
35. Tres niveles de coincidencia.
36. Búsqueda por municipio y radio.
37. Ficha con procedencia por atributo.
38. Comparador de hasta tres centros.
39. Explicación de vía de acceso y limitaciones.
40. Vista administrativa agregada.
41. Pruebas automáticas.
42. Docker y licencia abierta.

18. Pruebas obligatorias

- Un término explícito genera nivel A.
- Un servicio relacionado sin condición explícita no supera nivel B.
- Un centro genérico solo genera nivel C.
- La distancia no permite que C supere a A.
- TEA no se infiere desde discapacidad intelectual.
- Neurodivergencia obliga a precisar el apoyo buscado.
- Plazas autorizadas no se etiquetan como disponibles.
- Centro privado autorizado no se etiqueta como red pública.
- Si la vía de acceso falta, se muestra “debe confirmarse”.
- La procedencia existe para cada afirmación.
- Un centro sin coordenadas aparece en lista, pero no en el cálculo de radio.
- Los datos personales no se indexan ni exportan.

19. Plan de 21 días

Días	Entregable
1-2	Auditoría de fuentes, campos reales, licencias y seis perfiles
3-4	Ingesta, snapshots y modelo canónico
5-6	Taxonomía, sinónimos y revisión profesional
7-9	Motor de coincidencia A/B/C
10-11	Geografía, municipio y radio
12-13	Ficha, procedencia y comparador

14-15	Vías de acceso y advertencias
16	Vista administrativa agregada
17-18	Pruebas y revisión de falsos positivos
19	Docker, licencia y documentación
20	Demo, vídeo y dos casos reales
21	Contingencia, sin funciones nuevas

20. Historias de demostración

Caso 1. Daño cerebral adquirido

43. Buscar “daño cerebral adquirido”.
44. Seleccionar rehabilitación, logopedia y atención diurna.
45. Mostrar resultados de nivel A, B y C.
46. Abrir “¿Por qué aparece?”.
47. Comparar tres centros.
48. Mostrar vía de acceso e información pendiente.

Caso 2. Neurodivergencia

49. Introducir “neurodivergente”.
50. La aplicación solicita precisar: autismo, comunicación, apoyo educativo, laboral u otro.
51. Elegir TEA y etapa vital.
52. Mostrar solo coincidencias trazables.
53. Explicar por qué no se mezclan recursos genéricos de salud mental o discapacidad intelectual.

21. Guion de pitch

Las familias conocen la necesidad, pero no siempre el nombre administrativo del recurso. Madrid Apoyo Especializado traduce esa necesidad a centros sociales y sanitarios autorizados, separa especialización publicada de servicios relacionados y explica qué debe confirmarse antes de iniciar el acceso.

- 30 segundos: problema ciudadano.
- 45 segundos: búsqueda por necesidad.
- 60 segundos: niveles A, B y C.
- 45 segundos: procedencia y vía de acceso.
- 45 segundos: comparador.
- 30 segundos: uso administrativo.
- 20 segundos: cierre y escalabilidad.

22. Criterios de éxito

Métrica	Objetivo MVP
Precisión de nivel A	>= 95 % en muestra revisada
Precisión de nivel B	>= 85 %
Resultados con procedencia	100 %
Resultados sin vía de acceso	Marcados al 100 %
Confusión público/privado	0 casos en pruebas
Plazas autorizadas mostradas como vacantes	0 casos
Perfiles con al menos 3 resultados reales	Al menos 4 de 6
Búsqueda completa	Menos de 3 segundos sobre datos locales

23. Criterio de abandono o reducción

- Si menos de cuatro perfiles tienen tres resultados explícitos reales, reducir el MVP a los perfiles con evidencia suficiente.
- Si la especialización solo existe en PDF no estructurado, realizar una extracción limitada y revisada, no un scraping masivo.
- Si la vía de acceso no está disponible de forma fiable, mostrar únicamente la fuente oficial y “debe confirmarse”.
- Si no puede distinguirse público y privado, no ofrecer ese filtro.
- Si la taxonomía genera falsos positivos superiores al 15 %, limitar las coincidencias funcionales.

24. Primera tarea de la IA

54. Cargar el registro social, el registro sanitario y el directorio oficial.
55. Entregar cabecera, tipos y 20 filas minimizadas de cada fuente.
56. Localizar resultados reales para los seis perfiles.
57. Crear una matriz perfil × tipo de apoyo × fuente × número de centros.
58. Proponer taxonomía inicial y marcar toda inferencia.
59. Diseñar el modelo canónico y la procedencia por atributo.
60. Redactar pruebas antes de implementar el ranking.
61. Generar backlog imprescindible, importante, opcional y fuera del MVP.

Prompt breve v1.3 (histórico, sustituido por v1.7)

Actúa como arquitecto de datos, especialista en servicios sociales y sanitarios, accesibilidad cognitiva, GIS y privacidad. Construye Madrid Apoyo Especializado, un buscador transversal de centros autorizados de la Comunidad de Madrid por perfil y necesidad, no por categoría administrativa. Empieza con TEA,

daño cerebral adquirido, enfermedades neurodegenerativas, parálisis cerebral, lesión medular y atención temprana psicomotriz; y con rehabilitación, atención diurna, terapia ocupacional, logopedia, residencia y apoyo laboral. Integra el registro social, el registro sanitario y directorios oficiales. Clasifica los resultados en A: especialización explícita, B: servicios relacionados y C: orientación potencial. Nunca diagnostiques, prometas plaza, confundas autorización con red pública ni presentes plazas autorizadas como vacantes. Cada atributo debe conservar fuente y fecha. Implementa búsqueda territorial, ficha "¿Por qué aparece?", comparador sin ranking asistencial, vía de acceso, limitaciones, vista administrativa agregada, pruebas, Docker y licencia EUPL-1.2 o Apache-2.0. No inventes especializaciones ni servicios.

25. MEJORAS ESTRUCTURALES v1.1

La versión 1.1 reduce ambigüedad clínica, endurece la trazabilidad de las coincidencias y convierte la taxonomía en un producto gobernado. El objetivo es que cada resultado sea explicable, revisable y seguro para una familia y para un profesional público.

Principio v1.1: el sistema no responde "este centro sirve"; responde "este centro aparece por esta evidencia oficial, con este nivel de coincidencia y estas comprobaciones pendientes".

25.1. Separación de cuatro conceptos

Concepto	Qué significa	No significa
Perfil	Condición o colectivo explícitamente publicado	Diagnóstico realizado por la aplicación
Necesidad funcional	Apoyo buscado: rehabilitación, comunicación, atención diurna, alojamiento	Tratamiento clínico indicado
Servicio autorizado	Oferta asistencial o social declarada	Experiencia específica en todos los perfiles
Vía de acceso	Procedimiento oficial documentado	Plaza disponible o admisión garantizada

25.2. Núcleo y reserva

Nivel	Perfiles	Condición
Núcleo	TEA, daño cerebral adquirido, esclerosis múltiple/enfermedades degenerativas, parálisis cerebral	Al menos tres coincidencias A reales por perfil
Reserva	Lesión medular, atención temprana psicomotriz	Entrarán si existe evidencia suficiente y revisada
Posterior	TDAH, enfermedades raras, deterioro cognitivo, salud mental	Requieren nuevas taxonomías y revisión experta

25.3. Puerta de aceptación de perfil

62. Localizar al menos tres centros con coincidencia explícita nivel A.
63. Confirmar al menos una fuente estructurada o directorio oficial versionable.
64. Definir servicios relacionados sin inferir tratamiento.
65. Documentar etapa vital y vía de acceso cuando consten.
66. Revisar una muestra de resultados con una persona experta.
67. Aceptar el perfil solo si la precisión nivel A alcanza el 95 %.

```
profile_decision:
  profile_id: ...
  status: accepted | reserve | rejected
  explicit_centres: ...
  functional_centres: ...
  reviewed_sample: ...
  precision_level_a: ...
  precision_level_b: ...
  access_route_coverage_pct: ...
  limitations: [...]
```

26. GOBIERNO DE LA TAXONOMÍA

La taxonomía es el componente crítico del proyecto. No debe generarse mediante asociaciones libres de una IA. Cada término, sinónimo, exclusión y relación funcional debe quedar versionado y revisado.

Elemento	Ejemplo	Control
Término explícito	daño cerebral adquirido	Debe aparecer en fuente oficial o sinónimo validado
Sinónimo	DCA	Equivalencia exacta revisada
Término relacionado	rehabilitación	Solo genera nivel B
Exclusión	discapacidad intelectual no implica TEA	Regla negativa obligatoria
Etapa vital	atención temprana → primera infancia	Filtro bloqueante
Término ambiguo	neurodivergente	Obliga a desambiguar antes de buscar

```
taxonomy_entry:
  term_id: ...
  preferred_label: ...
  synonyms: [...]
  related_services: [...]
  excluded_inferences: [...]
  allowed_life_stages: [...]
  source_url: ...
  reviewer_role: social | healthcare | accessibility
  reviewed_at: ...
  version: 1.0.0
  status: approved | experimental | deprecated
```

26.1. Reglas negativas obligatorias

- TEA no se infiere desde discapacidad intelectual.
- Salud mental no se infiere desde neurodivergencia.

- Neurología no demuestra especialización en daño cerebral o enfermedad neurodegenerativa.
- Fisioterapia no demuestra rehabilitación neurológica.
- Atención temprana no implica psicomotricidad si no consta.
- Centro para discapacidad física no demuestra lesión medular o parálisis cerebral.
- Plazas autorizadas no demuestran disponibilidad.
- Autorización privada no demuestra concierto ni financiación pública.

27. MODELO DE EVIDENCIA Y EXPLICABILIDAD

Nivel	Condición necesaria	Mensaje al usuario
A1	Condición y apoyo aparecen explícitamente	Especialización y apoyo publicados
A2	Condición explícita, apoyo no detallado	Especialización publicada; confirme el apoyo concreto
B1	Dos o más servicios relacionados y etapa compatible	Servicios relacionados; especialización no confirmada
B2	Un servicio relacionado de alta relevancia	Posible recurso; requiere confirmación
C	Solo sector o tipo genérico	Orientación general; no consta especialización

Mejora clave: sustituir A/B/C simples por A1, A2, B1, B2 y C para explicar mejor la fuerza de la evidencia.

27.1. Explicación obligatoria

```
match_explanation:
  level: A1
  because:
    - "La fuente oficial menciona daño cerebral adquirido"
    - "El centro declara logopedia y terapia ocupacional"
  does_not_confirm:
    - plazas disponibles
    - admisión directa
    - adecuación clínica individual
  sources:
    - attribute: specialisation
      source_url: ...
    - attribute: services
      source_url: ...
```

28. VÍA DE ACCESO Y ESTADO DE DISPONIBILIDAD

La vía de acceso debe tratarse como una dimensión separada del centro. Un resultado no puede inducir a pensar que basta con llamar o desplazarse.

Estado	Etiqueta
Documentada y directa	Acceso directo según fuente oficial

Documentada con derivación	Requiere derivación o valoración
Dependencia/PIA	Requiere reconocimiento y programa compatible
Privado autorizado	Consulte condiciones y financiación
No documentada	Debe confirmarse con el organismo competente

```
access_route:
  access_type: direct | referral | dependency_pia | private_contact | unknown
  competent_body: ...
  official_description: ...
  source_url: ...
  checked_at: ...
  availability_known: false
  waiting_list_known: false
```

29. ESTRATEGIA DE EXTRACCIÓN Y CALIDAD

68. Priorizar CSV y JSON.
69. Usar directorios oficiales como enriquecimiento limitado y revisado.
70. No extraer automáticamente especializaciones desde texto libre sin mantener fragmento y fuente.
71. Guardar instantáneas y hashes.
72. Comparar versiones para detectar cambios de especialización, plazas o acreditación.
73. Marcar como no estructurado cualquier atributo obtenido de PDF o página oficial.

Calidad	Condición
A. Verificada	Atributo estructurado o revisado, fuente y fecha completas
B. Utilizable con advertencia	Fuente oficial no estructurada o fecha antigua
C. Experimental	Mapeo funcional pendiente de ampliar muestra
D. No publicable	Sin procedencia, contradicción no resuelta o inferencia prohibida

30. PRIVACIDAD, ACCESIBILIDAD Y LENGUAJE

- No registrar diagnósticos personales ni búsquedas asociadas a identidad.
- Analítica de búsquedas solo agregada y con umbral mínimo.
- No conservar ubicación exacta del usuario; usar municipio o geolocalización efímera.
- Aplicar WCAG 2.2 AA y lenguaje claro.
- Ofrecer modo de lectura fácil con frases breves y definiciones.
- No utilizar rojo/verde como único código visual.
- Permitir navegación por teclado y lectores de pantalla.
- Evitar términos estigmatizantes y conservar la denominación oficial junto a una explicación ciudadana.

31. MATRIZ DE PRUEBAS CRÍTICAS

Caso	Entrada	Esperado
TAX-001	TEA explícito en fuente	A1
TAX-002	Discapacidad intelectual sin TEA	No inferir TEA
TAX-003	Neurología sin perfil explícito	Máximo B2
TAX-004	Fisioterapia genérica	No inferir rehabilitación neurológica
TAX-005	Neurodivergente	Solicitar precisión
TAX-006	Atención temprana sin psicomotricidad	No afirmar psicomotricidad
ACC-001	Requiere derivación	Mostrar derivación
ACC-002	Vía ausente	Debe confirmarse
ACC-003	Privado autorizado	No etiquetar red pública
CAP-001	30 plazas autorizadas	No mostrar 30 vacantes
GEO-001	Centro sin coordenadas	Aparece en lista, no en radio
RANK-001	A a 30 km y C a 2 km	A antes que C
PROV-001	Atributo sin fuente	Bloquear publicación
PRIV-001	Búsqueda individual	No persistir perfil
A11Y-001	Filtro solo por color	Prueba fallida

31.1. Métricas de validación

Métrica	Umbral
Precisión A1/A2	>= 95 %
Precisión B1/B2	>= 85 %
Resultados con procedencia	100 %
Inferencias prohibidas	0
Confusión plaza autorizada/vacante	0
Confusión público/privado	0

Cobertura de vía de acceso	>= 80 % o advertencia visible
Pruebas críticas fallidas	0

32. EXPERIENCIA CIUDADANA MEJORADA

74. Elegir perfil o escribir una necesidad.
75. Desambiguar términos amplios.
76. Seleccionar apoyo buscado y etapa vital.
77. Mostrar resultados en grupos: especialización publicada, servicios relacionados y orientación.
78. Abrir “¿Por qué aparece?”.
79. Comparar hasta tres centros.
80. Mostrar vía de acceso y preguntas pendientes.
81. Generar una ficha imprimible para preparar el contacto con el centro o profesional.

32.1. Ficha para preparar el contacto

- Qué declara oficialmente el centro.
- Qué apoyo debe confirmarse.
- Si la vía de acceso exige derivación, dependencia o PIA.
- Si las plazas disponibles son desconocidas.
- Teléfono, correo y enlace oficial.
- Preguntas recomendadas según el perfil y apoyo.
- Fecha de consulta de la información.

33. UTILIDAD ADMINISTRATIVA

- Términos ciudadanos que no encuentran equivalencia.
- Perfiles con pocas coincidencias explícitas.
- Municipios sin recursos A1/A2 dentro de un radio.
- Especializaciones presentes solo en PDF y no en datos abiertos.
- Fichas sin vía de acceso, coordenadas, plazas o acreditación.
- Cambios entre versiones del registro.
- Concentración de plazas autorizadas por perfil, sin confundirlas con disponibilidad.

La vista administrativa no clasifica centros por calidad. Evalúa la encontrabilidad, completitud y distribución de la información oficial.

34. MVP REDUCIDO Y GANADOR

Imprescindible	Importante	Opcional	Fuera del MVP
4 perfiles núcleo; 4 apoyos; A1/A2/B1/B2/C; municipio/radio; procedencia; comparador; vía de acceso	Lesión medular y atención temprana; histórico; ficha imprimible; vista administrativa	Más perfiles; lenguaje natural libre; mapas de cobertura; multilingüe	Diagnóstico, recomendación clínica, plazas en tiempo real, ranking de calidad, chatbot sanitario

Se recomienda demostrar dos historias reales: daño cerebral adquirido y TEA. Las demás categorías prueban extensibilidad, pero no deben saturar la presentación.

35. PLAN v1.1 DE 21 DÍAS

Días	Resultado
1-2	Auditoría de fuentes y puerta de aceptación de cuatro perfiles
3-4	Modelo canónico, snapshots y procedencia
5-7	Taxonomía, reglas negativas y revisión experta
8-10	Motor A1/A2/B1/B2/C y pruebas
11-12	Geografía, filtros y ranking por evidencia
13-14	Vía de acceso y ficha de contacto
15-16	Comparador y accesibilidad WCAG 2.2 AA
17	Vista administrativa agregada
18	Validación de precisión y falsos positivos
19	Docker, licencia, README y metodología
20	Demo con dos casos reales y vídeo
21	Contingencia, sin nuevas funciones

36. PRIMERA ORDEN v1.1

Audita primero TEA, daño cerebral adquirido, enfermedad neurodegenerativa y parálisis cerebral. Para cada perfil entrega: centros A1/A2 reales, centros B1/B2, fuentes exactas, servicios relacionados, etapa vital, vía de acceso, plazas autorizadas, naturaleza pública o privada y limitaciones. No desarrolles la interfaz hasta confirmar al menos tres coincidencias explícitas por perfil y una precisión preliminar A >= 95 %.

Prompt breve v1.3 (histórico, sustituido por v1.7)

Construye Madrid Apoyo Especializado como buscador ciudadano por perfil y apoyo, no como recomendador médico. Empieza con TEA, daño cerebral adquirido, enfermedades neurodegenerativas y parálisis cerebral. Separa perfil, necesidad funcional, servicio autorizado y vía de acceso. Clasifica A1:

condición y apoyo explícitos; A2: condición explícita; B1: varios servicios relacionados; B2: un servicio relevante; C: orientación genérica. La distancia nunca supera la evidencia. Implementa reglas negativas: discapacidad intelectual no implica TEA, neurología no implica DCA y fisioterapia no implica rehabilitación neurológica. Cada atributo debe tener fuente, fecha, método y nivel de evidencia. No confundas autorización, red pública, plazas autorizadas y vacantes. Añade comparador, ficha "¿Por qué aparece?", vía de acceso, preguntas para preparar el contacto, analítica agregada, WCAG 2.2 AA, pruebas, Docker y licencia abierta. No inventes especializaciones, diagnósticos ni disponibilidad.

37. REORIENTACIÓN DEL PRODUCTO v1.2

La versión 1.2 convierte el buscador en un orientador verificable de recursos. El resultado principal deja de ser una lista de centros y pasa a ser una respuesta estructurada: qué recursos pueden ser relevantes, por qué aparecen, cómo se accede y qué información debe confirmarse.

Promesa v1.2: "Entiende qué recursos oficiales pueden encajar, por qué aparecen y cuál es el siguiente paso seguro".

37.1. Resultado ciudadano obligatorio

Bloque	Respuesta que debe ofrecer
Qué puede encajar	Centros A1/A2 y, separadamente, B1/B2
Por qué aparece	Evidencia literal, servicios relacionados y fuente
Cómo se accede	Directo, derivación, dependencia/PIA, privado o desconocido
Qué no se sabe	Vacantes, listas de espera, coste, admisión o adecuación individual
Qué hacer ahora	Contacto, organismo competente, documentación o confirmación pendiente
Qué alternativa existe	Ampliación de radio, otro apoyo o recurso de orientación

37.2. Flujo de búsqueda en dos minutos

82. Elegir un perfil validado o describir una necesidad.
83. Precisar el apoyo buscado mediante preguntas cerradas.
84. Seleccionar etapa vital y territorio.
85. Recibir resultados agrupados por fuerza de evidencia.
86. Abrir la explicación y la vía de acceso.
87. Comparar hasta tres recursos.
88. Descargar una ficha para preparar el contacto.

38. DISEÑO PARA INCERTIDUMBRE Y AUSENCIA DE RESULTADOS

Un buscador responsable debe explicar los vacíos y no rellenarlos con asociaciones débiles.

Situación	Respuesta
Sin coincidencias A	Mostrar B por separado y explicar que no consta especialización explícita
Sin coincidencias A ni B	Mostrar recursos de orientación, no centros supuestamente especializados
Sin vía de acceso	Indicar “debe confirmarse” y enlazar la fuente competente
Fuentes contradictorias	No elegir una en silencio; mostrar ambas y bloquear el atributo
Fuente antigua	Mostrar fecha y nivel B de calidad
Centro sin coordenadas	Incluir en listado, excluir del radio y mapa
Término ambiguo	Solicitar precisión antes de ejecutar la búsqueda

```
no_result_response:
  query_profile: ...
  explicit_matches: 0
  functional_matches: 2
  message: "No consta una especialización explícita en las fuentes consultadas"
  alternatives:
    - widen_radius
    - choose_related_support
    - contact_orientation_service
  never_infer_specialisation: true
```

39. JERARQUÍA DE FUENTES Y CONFLICTOS

Prioridad	Fuente	Uso
1	Registro estructurado vigente	Identidad, autorización, tipo, plazas y localización
2	Directorio oficial especializado	Especialización, capacidad o red específica
3	Ficha oficial del organismo o centro	Servicios y vía de acceso
4	Documento oficial no estructurado	Enriquecimiento revisado
No válida	Agregadores, reseñas o publicidad	No generan evidencia A o B

- La fuente más reciente no sustituye automáticamente a una fuente de mayor autoridad.
- Una contradicción en plazas, especialización o vía de acceso bloquea ese atributo.
- El centro puede seguir apareciendo si la identidad y ubicación son válidas.
- El usuario debe ver “información contradictoria pendiente de comprobación”.
- La resolución manual conserva revisor, fecha, decisión y fragmentos de evidencia.

```
conflict_record:
  centre_id: ...
  attribute: authorised_places
  source_a: {value: 30, date: 2026-10-01, type: registry}
  source_b: {value: 25, date: 2026-09-15, type: official_directory}
  status: unresolved
  public_value: null
  public_message: "La capacidad publicada no es coincidente"
```

40. REVISIÓN EXPERTA Y PUBLICACIÓN

Los mapeos clínicos y sociales requieren revisión explícita. El sistema no debe publicar una nueva relación solo porque la sugiera un modelo de lenguaje.

Rol	Responsabilidad
Especialista social	Tipos de recursos, acceso por dependencia/PIA y terminología social
Profesional sanitario	Relaciones entre perfiles y ofertas asistenciales, sin diagnóstico
Especialista en accesibilidad cognitiva	Lenguaje claro, lectura fácil y navegación
Responsable del dato	Fuente, vigencia y resolución de conflictos
Equipo técnico	Implementación reproducible y pruebas

```
review_decision:
  mapping_id: ...
  proposed_level: B1
  reviewers:
    - role: healthcare
      decision: approve
    - role: social
      decision: approve_with_limits
  approved_message: ...
  limitations: [...]
  valid_from: ...
  review_due: ...
```

40.1. Ciclo de vida del mapeo

- Borrador.
- Pendiente de revisión.
- Aprobado.
- Aprobado con limitaciones.
- Experimental.
- Suspendido por conflicto.
- Obsoleto.

41. ALGORITMO DE ORDENACIÓN EXPLICABLE

La ordenación debe ser lexicográfica, no una puntuación opaca. Primero se ordena por evidencia, después por compatibilidad del apoyo, etapa vital, calidad de fuente y distancia.

```
sort_key = (
  evidence_rank,        # A1 < A2 < B1 < B2 < C
```

```
  support_mismatch,     # 0 si coincide el apoyo
  life_stage_mismatch,  # 0 si es compatible
  source_quality_rank,  # A < B < C < D
  distance_km
)

Regla: ninguna distancia permite que C supere A1/A2.
```

Factor	Bloqueante	Efecto
Etapa vital incompatible	Sí	Excluir resultado
Especialización explícita	No	Prioridad A
Apoyo explícito	No	A1 frente a A2
Vía de acceso desconocida	No	Advertencia visible
Centro sin coordenadas	No	Sin distancia ni mapa
Fuente D	Sí	No publicable

42. TARJETAS DE SIGUIENTE PASO

Los resultados deben terminar en una acción concreta, sin prometer admisión.

Vía	Tarjeta
Directa	Contacte con el centro y confirme perfil, apoyo, disponibilidad y condiciones
Derivación	Solicite orientación al servicio derivante indicado por la fuente
Dependencia/PIA	Compruebe reconocimiento de dependencia y compatibilidad del PIA
Privado autorizado	Confirme precio, cobertura, admisión y servicios incluidos
Desconocida	Use el contacto oficial para confirmar el procedimiento antes de desplazarse

43. ANALÍTICA DE NECESIDADES NO CUBIERTAS

- Registrar únicamente términos normalizados y municipio agregado.
- No conservar texto libre original si puede contener información de salud.
- No almacenar ubicación exacta, identidad ni identificadores de sesión persistentes.
- No publicar combinaciones con menos de cinco consultas.
- Separar “sin oferta explícita” de “sin información estructurada”.
- Mostrar tendencias mensuales, no perfiles individuales.

```
aggregated_query_metric:
  month: 2026-11
  profile_id: acquired_brain_injury
  support_id: day_care
  municipality_group: south_madrid
  query_count: 23
  explicit_result_count: 2
  functional_result_count: 7
  zero_result_rate: 0.13
```

44. CASOS DE PRUEBA v1.2

ID	Escenario	Esperado
EV-001	Condición y apoyo literales	A1
EV-002	Condición literal, apoyo ausente	A2
EV-003	Dos servicios relacionados	B1
EV-004	Un servicio relacionado	B2
EV-005	Solo sector genérico	C
NEG-001	Neurología sin DCA	No elevar a A
NEG-002	Discapacidad física sin lesión medular	Máximo C
NEG-003	TEA inferido desde discapacidad intelectual	Bloquear
NEG-004	Plazas autorizadas como vacantes	Bloquear
SRC-001	Registro y directorio contradicen plazas	Atributo nulo y aviso
SRC-002	Web promocional contradice registro	Prevalece registro; conservar conflicto
SRC-003	Atributo sin URL	No publicable
NORES-001	Sin A, con B	Mostrar B separado
NORES-002	Sin A ni B	Mostrar orientación, no C como especializado
NORES-003	Término neurodivergente	Desambiguar
ACC-004	PIA documentado	Tarjeta PIA
ACC-005	Acceso desconocido	Debe confirmarse
GEO-002	Sin coordenadas	Lista sí, radio no
SORT-001	C cercano y A lejano	A primero

PRIV-002	Texto libre con diagnóstico	No persistir
PRIV-003	Cuatro consultas agregadas	Suprimir analítica
A11Y-002	Explicación solo por icono	Fallo

45. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL MVP

Criterio	Umbral
Perfiles núcleo con >=3 centros A1/A2	4 perfiles
Precisión A1/A2	>=95 %
Precisión B1/B2	>=85 %
Resultados con explicación y procedencia	100 %
Resultados con vía de acceso o aviso	100 %
Inferencias negativas vulneradas	0
Contradicciones publicadas sin aviso	0
Datos de salud personales almacenados	0
Pruebas críticas fallidas	0
Tiempo de respuesta local	<3 segundos

46. DEMOSTRACIÓN GANADORA

89. Buscar daño cerebral adquirido y seleccionar rehabilitación más atención diurna.
90. Mostrar A1, A2 y B1 con mensajes distintos.
91. Abrir “¿Por qué aparece?” y enseñar fragmentos y fuentes.
92. Comparar tres centros sin puntuación asistencial.
93. Mostrar la vía de acceso y generar la ficha de contacto.
94. Cambiar a “neurodivergente” y demostrar la desambiguación segura.
95. Cerrar con la vista administrativa de búsquedas sin resultado explícito.

Mensaje de cierre: la ciudadanía no debería conocer la estructura administrativa para encontrar apoyo. La Administración sí debe saber qué información falta para que ese apoyo sea encontrable.

47. BACKLOG v1.2

Imprescindible	Importante	Opcional	Fuera del MVP
4 perfiles; 4 apoyos; A1-A2-B1-B2-C; reglas negativas; procedencia; conflictos; vía de acceso; comparador; ficha de contacto	Vista administrativa; histórico; accesibilidad lectura fácil; analítica de cero resultados	Lesión medular; atención temprana; multilingüe; más radios	Diagnóstico; chatbot clínico; plazas en tiempo real; reseñas; ranking de calidad; predicción de admisión

48. PRIMERA ORDEN v1.2

Antes de programar la interfaz, construye una matriz real para TEA, daño cerebral adquirido, enfermedades neurodegenerativas y parálisis cerebral. Para cada centro registra evidencia literal, servicio, etapa vital, vía de acceso, naturaleza pública o privada, plazas autorizadas, fuente, fecha y conflictos. Clasifica provisionalmente A1/A2/B1/B2/C y revisa manualmente al menos 20 resultados por perfil. Reduce o descarta cualquier perfil que no alcance tres coincidencias explícitas y 95 % de precisión A.

Prompt breve v1.3 (histórico, sustituido por v1.7)

Construye Madrid Apoyo Especializado como un orientador verificable, no como buscador médico. Responde qué recursos pueden encajar, por qué aparecen, cómo se accede, qué no se sabe y cuál es el siguiente paso. Empieza con TEA, daño cerebral adquirido, enfermedades neurodegenerativas y parálisis cerebral. Usa A1, A2, B1, B2 y C con orden lexicográfico por evidencia; la distancia nunca supera la evidencia. Implementa reglas negativas y desambiguación de términos como neurodivergente. Cada atributo necesita fuente, fecha, método y calidad; las contradicciones bloquean el atributo. Separa autorización, red pública, plazas autorizadas, vacantes y vía de acceso. No almacenes texto de salud ni ubicación exacta. Añade "¿Por qué aparece?", comparador, tarjetas de siguiente paso, ficha imprimible, analítica agregada de búsquedas sin resultado, pruebas, WCAG 2.2 AA, Docker y licencia abierta. No inventes diagnósticos, especializaciones, disponibilidad ni admisión.

49. TAXONOMÍA AMPLIABLE Y VERSIONADA v1.3

La taxonomía deja de ser una lista fija. Se convierte en un subsistema configurable que permite añadir, dividir, fusionar, suspender, sustituir y retirar categorías sin modificar el motor de búsqueda ni perder la reproducibilidad histórica.

Principio v1.3: conservar el vocabulario ciudadano, pero convertirlo en búsquedas precisas mediante perfiles, necesidades funcionales, apoyos, etapas vitales y vías de acceso independientes.

49.1. Cinco dimensiones independientes

Dimensión	Ejemplos	Función
Perfil o condición publicada	TEA, DCA, lesión medular, esclerosis múltiple	Evidencia explícita del colectivo o condición
Necesidad funcional	Comunicación, movilidad, autonomía, regulación sensorial	Describe el apoyo buscado sin diagnosticar
Tipo de apoyo	Logopedia, fisioterapia, atención diurna, residencia	Filtra la prestación o recurso
Etapa vital	Primera infancia, menor, adulto, mayor	Bloquea recursos incompatibles
Vía de acceso	Directa, derivación, dependencia/PIA, privada	Explica el siguiente paso

50. CATÁLOGO AMPLIADO DE PERFILES

Familia	Perfiles candidatos
Neurológicos y neurodegenerativos	Daño cerebral adquirido; ictus y secuelas; traumatismo craneoencefálico; lesión medular; esclerosis múltiple; ELA; Párkinson; Huntington; ataxias; enfermedades neuromusculares; demencias; Alzheimer; parálisis cerebral; epilepsia solo si consta
Neurodesarrollo y atención temprana	TEA; TDAH; trastorno del desarrollo del lenguaje; discapacidad intelectual; retraso global del desarrollo; atención temprana; pluridiscapacidad
Discapacidad física y sensorial	Discapacidad física; movilidad reducida; discapacidad visual; auditiva; sordoceguera; amputación; productos de apoyo; comunicación aumentativa y alternativa
Salud mental y apoyo psicosocial	Enfermedad mental grave; rehabilitación psicosocial; rehabilitación laboral; soporte social; apoyo comunitario; alojamiento supervisado; atención residencial
Dependencia y mayores	Promoción de autonomía; centro de día; residencia; respiro familiar; deterioro cognitivo; cuidados de larga duración

50.1. Necesidades funcionales transversales

- Comunicación y lenguaje.
- Movilidad, equilibrio y coordinación.
- Motricidad fina y gruesa.
- Deglución.
- Autonomía personal y actividades de la vida diaria.
- Cognición y memoria.
- Regulación sensorial.
- Habilidades sociales y conducta.

- Integración comunitaria.
- Preparación laboral y apoyo educativo.
- Apoyo familiar y respiro.
- Alojamiento y atención diurna.

51. CICLO DE VIDA DE CATEGORÍAS

Estado	Uso
draft	Propuesta interna aún no revisada
pending_review	Pendiente de revisión social o sanitaria
approved	Disponible para búsquedas públicas
experimental	Visible con advertencia y métricas separadas
suspended	Retirada temporalmente por conflicto o precisión baja
deprecated	Sustituida por categorías más precisas
archived	Solo para reproducir búsquedas históricas

```
category_lifecycle:
  profile_id: psychomotor_needs
  status: deprecated
  replacements:
    - early_intervention
    - gross_motor_support
    - fine_motor_support
    - occupational_therapy
  deprecated_at: 2027-02-01
  reason: "Categoría demasiado amplia"
  redirect_searches: true
```

51.1. Motivos para suspender o retirar

- Falsos positivos superiores al umbral.
- Sin correspondencia oficial suficiente.
- Mezcla perfiles clínicos o sociales diferentes.
- Terminología obsoleta o estigmatizante.
- Fuente oficial retirada o no reproducible.
- Menos de tres coincidencias explícitas.
- Vía de acceso incompatible con la presentación pública.
- Riesgo de asociación clínica impropia.

52. ESQUEMA COMPLETO DE UNA CATEGORÍA

```
profile:
  id: multiple_sclerosis
  preferred_label: "Esclerosis múltiple"
  broader_profiles: [neurodegenerative_conditions, physical_disability]
  explicit_terms: ["esclerosis múltiple", "EM"]
  excluded_terms: ["electromedicina", "emergencias"]
```

```
  related_needs: [mobility, autonomy, communication]
  related_supports: [neurological_rehabilitation, physiotherapy, occupational_therapy, speech_therapy, day_care,
residential_support]
  allowed_life_stages: [adult, older_adult]
  forbidden_inferences:
    - "neurología implica especialización en esclerosis múltiple"
    - "fisioterapia implica rehabilitación neurológica"
  evidence_requirements:
    A1: {explicit_profile: true, explicit_support: true}
    A2: {explicit_profile: true}
    B1: {minimum_related_services: 2}
  access_routes: [referral, dependency_pia, private_contact]
  review:
    status: approved
    taxonomy_version: 1.3.0
    reviewer_roles: [healthcare, social_services]
    reviewed_at: 2026-11-08
    review_due: 2027-11-08
```

53. FLUJO PARA AÑADIR UNA CATEGORÍA

96. Registrar la solicitud y el término ciudadano.
97. Identificar equivalentes oficiales y posibles ambigüedades.
98. Localizar menciones explícitas en fuentes oficiales.
99. Definir sinónimos, abreviaturas y términos excluidos.
100. Asignar necesidades funcionales y apoyos relacionados.
101. Definir etapas vitales y vías de acceso.
102. Crear reglas negativas y prohibiciones de inferencia.
103. Revisar manualmente resultados A y B.
104. Medir precisión y documentar limitaciones.
105. Aprobar, dejar experimental o rechazar.
106. Publicar una nueva versión de la taxonomía.
107. Mantener redirecciones desde términos anteriores.

53.1. Puerta de aceptación

Criterio	Umbral recomendado
Centros con coincidencia explícita	>=3
Fuente oficial reproducible	>=1
Muestra revisada	20 resultados o todos si hay menos
Precisión A1/A2	>=95 %
Precisión B1/B2	>=85 %
Reglas negativas	Documentadas
Etapa vital	Definida
Vía de acceso	Definida o advertencia obligatoria

53.2. Destinos alternativos si no supera la puerta

- Necesidad funcional.
- Sinónimo de entrada.
- Filtro experimental.
- Categoría pendiente de revisión.
- Término de desambiguación.
- No publicar.

54. TRATAMIENTO DE TÉRMINOS AMPLIOS

54.1. Neurodivergente

Se conserva como término ciudadano, pero no ejecuta una búsqueda directa de centros. Activa una desambiguación obligatoria.

```
entry_terms:
  neurodivergent:
    type: disambiguation
    direct_search: false
    options:
      - autism
      - adhd
      - communication_support
      - sensory_regulation
      - social_skills
      - early_intervention
      - educational_support
      - employment_support
```

54.2. Psicomotriz

Se divide en necesidades observables: motricidad gruesa, motricidad fina, coordinación, equilibrio, desarrollo motor, integración sensorial, autonomía, fisioterapia, terapia ocupacional y atención temprana. Fisioterapia u ocupacional no prueban psicomotricidad si la fuente no lo expresa.

55. ARQUITECTURA DE CONFIGURACIÓN

```
config/
|-- profiles/
|   |-- neurological.yaml
|   |-- neurodevelopmental.yaml
|   |-- physical_disability.yaml
|   |-- sensory_disability.yaml
|   |-- mental_health.yaml
|   `-- older_people.yaml
|-- needs/
|   |-- communication.yaml
|   |-- mobility.yaml
|   |-- cognition.yaml
|   `-- sensory_regulation.yaml
|-- supports/
|   |-- rehabilitation.yaml
|   |-- day_care.yaml
|   |-- residential.yaml
|   `-- employment.yaml
|-- life_stages.yaml
|-- access_routes.yaml
|-- exclusions.yaml
|-- entry_terms.yaml
`-- taxonomy_manifest.yaml
```

```
taxonomy:
  version: 1.3.0
  released_at: 2026-11-08
  active_profiles: 4
  experimental_profiles: 2
  pending_profiles: 7
  deprecated_profiles: 0
  minimum_review_requirements:
    level_a_precision: 0.95
    level_b_precision: 0.85
    minimum_explicit_centres: 3
```

56. VERSIONADO Y MIGRACIONES

- Usar versionado semántico: mayor para cambios incompatibles, menor para nuevas categorías y parche para correcciones.
- Guardar taxonomy_version en cada búsqueda reproducible y resultado exportado.
- No recalcular silenciosamente resultados históricos con una taxonomía nueva.
- Crear migraciones para fusiones, divisiones y sustituciones.
- Mostrar al usuario si una búsqueda guardada utiliza una categoría obsoleta.

```
taxonomy_migration:
  from_version: 1.3.0
  to_version: 1.4.0
  operation: split
  source_profile: psychomotor_needs
  target_profiles: [gross_motor_support, fine_motor_support, early_intervention]
  preserve_historical_results: true
  redirect_new_searches: true
```

57. PROPUESTAS DE CATEGORÍAS DESDE BÚSQUEDAS AGREGADAS

La aplicación puede detectar términos recurrentes sin equivalencia y generar propuestas para revisión, nunca activar categorías automáticamente.

```
candidate_profile:
  user_term: "ELA"
  normalized_term: "esclerosis lateral amiotrófica"
  monthly_query_count: 86
  explicit_results: 0
  potentially_related_centres: 9
  status: pending_expert_review
  privacy_threshold_met: true
```

- No conservar el texto original si contiene información personal.
- Aplicar umbral mínimo de cinco consultas agregadas.
- Separar ausencia de oferta y ausencia de descripción estructurada.
- Requerir revisión experta antes de crear sinónimos o perfiles.

58. PANEL DE GESTIÓN TAXONÓMICA

Vista	Funciones
Categorías	Estado, versión, precisión, centros explícitos y fecha de revisión

Propuestas	Términos buscados, volumen agregado y posibles equivalencias
Conflictos	Relaciones suspendidas o fuentes contradictorias
Migraciones	Divisiones, fusiones, sustituciones y redirecciones
Calidad	Falsos positivos, falsos negativos y perfiles sin resultados
Revisión	Tareas pendientes por rol experto

59. PRUEBAS DE TAXONOMÍA

ID	Escenario	Esperado
TAX-LIFE-001	Categoría draft	No visible públicamente
TAX-LIFE-002	Categoría suspended	No genera resultados
TAX-LIFE-003	Categoría deprecated	Redirige a sustitutas
TAX-LIFE-004	Resultado histórico	Conserva versión antigua
TAX-ADD-001	Nueva categoría con 2 centros explícitos	No aprobar
TAX-ADD-002	Precisión A 94 %	No aprobar
TAX-ADD-003	Precisión A 96 % y B 86 %	Aprobar si cumple resto
TAX-NEG-001	Neurología para esclerosis múltiple	Máximo B2
TAX-NEG-002	Fisioterapia para rehabilitación neurológica	No inferir
TAX-AMB-001	Neurodivergente	Desambiguación obligatoria
TAX-AMB-002	Psicomotriz	Mostrar necesidades desglosadas
TAX-MIG-001	División de categoría	Nuevas búsquedas redirigidas
TAX-MIG-002	Búsqueda histórica	No recalcular
TAX-PRIV-001	Término con menos de 5 consultas	No mostrar en panel

60. POLÍTICA DE AMPLIACIÓN DEL MVP

Estado inicial	Categorías

Activas	TEA, daño cerebral adquirido, enfermedades neurodegenerativas, parálisis cerebral
Experimentales	Lesión medular, atención temprana psicomotriz
Pendientes	TDAH, ELA, Párkinson, Alzheimer, enfermedades raras, discapacidad auditiva, discapacidad visual

El MVP demuestra que la taxonomía puede crecer, pero solo publica categorías validadas. La amplitud técnica no sustituye la precisión.

61. PRIMERA ORDEN v1.3

Integra la taxonomía fuera del código. Crea archivos separados para perfiles, necesidades, apoyos, etapas vitales, vías de acceso, exclusiones y términos de entrada. Implementa estados del ciclo de vida, versionado semántico, migraciones y redirecciones. Mantén activas únicamente cuatro categorías validadas; deja dos experimentales y siete pendientes. No actives una categoría sin tres centros explícitos, fuente oficial, revisión de muestra, precisión A >=95 %, precisión B >=85 %, reglas negativas y etapa vital definida.

Prompt breve v1.3 (histórico, sustituido por v1.7)

Construye Madrid Apoyo Especializado con una taxonomía externa, ampliable y versionada. Separa perfil, necesidad funcional, tipo de apoyo, etapa vital y vía de acceso. Permite añadir, dividir, fusionar, suspender, sustituir, deprecar y archivar categorías sin cambiar el motor ni perder resultados históricos. Usa estados draft, pending_review, approved, experimental, suspended, deprecated y archived. Conserva neurodivergente y psicomotriz como términos de desambiguación, no como diagnósticos o especializaciones automáticas. Exige tres centros explícitos, fuente oficial, muestra revisada, precisión A >=95 %, precisión B >=85 %, reglas negativas y etapa vital antes de aprobar. Implementa versionado semántico, migraciones, redirecciones, panel taxonómico, propuestas derivadas solo de analítica agregada y pruebas de ciclo de vida. Mantén cuatro perfiles activos, dos experimentales y el resto pendiente. No inventes equivalencias, especializaciones ni disponibilidad.

62. BÚSQUEDA ACUMULATIVA Y MAPA v1.4

La versión 1.4 convierte todos los criterios de búsqueda en filtros acumulativos y sincroniza una lista ordenada con un mapa accesible. Cada selección refina el mismo conjunto de resultados; ningún filtro sustituye, reinicia ni ignora los criterios anteriores.

Principio v1.4: perfil + necesidad funcional + apoyo + etapa vital + ubicación + red + accesibilidad se aplican conjuntamente mediante lógica AND entre dimensiones y OR controlado dentro de una misma

dimensión.

62.1. Semántica acumulativa de filtros

- Entre dimensiones se aplicará AND. Ejemplo: TEA Y logopedia Y menor Y radio de 20 km.
- Dentro de una dimensión multiselección se aplicará OR por defecto. Ejemplo: logopedia O terapia ocupacional, manteniendo el resto de filtros.
- La interfaz mostrará chips activos, número de resultados y la acción “Quitar” para cada criterio.
- Cambiar municipio, población o radio recalculará los resultados sin borrar perfil, apoyos, etapa vital ni preferencias de red.
- La ubicación inicial será la geolocalización efímera del navegador, si la persona la autoriza. Si no, se solicitará municipio o población.
- La lista de poblaciones incluirá únicamente municipios de la Comunidad de Madrid y será buscable.
- “Limpiar filtros” será la única acción que restablezca toda la búsqueda.
- Los filtros incompatibles no devolverán asociaciones débiles: mostrarán cero resultados, explicarán qué combinación lo provoca y permitirán retirar un criterio.

```
filter_logic:
  across_dimensions: AND
  within_same_dimension: OR
  preserve_on_location_change: true
  reset_only_by_explicit_action: true
  zero_results:
    explain_conflicting_filters: true
    never_relax_silently: true
```

62.2. Estado reproducible de la búsqueda

```
search_request:
  profiles: [autism]
  functional_needs: [communication]
  support_types: [speech_therapy, occupational_therapy]
  life_stages: [minor]
  location:
    mode: browser | municipality | population
    municipality_code: null
    coordinates_ephemeral: true
    radius_km: 20
  network_preferences: [public_network, private_authorised]
  accessibility_features: [step_free_access]
  combine:
    dimensions: AND
    values_within_dimension: OR
  taxonomy_version: 1.4.0
```

63. MAPA SINCRONIZADO CON LA LISTA

- El mapa y la lista representan exactamente el mismo conjunto filtrado.

- El mapa se centrará en la ubicación del navegador autorizada o en el municipio/población seleccionados.
- Los resultados se ordenarán primero por evidencia A1, A2, B1, B2 y C; dentro del mismo nivel, por coincidencia de apoyo, etapa vital, calidad de fuente y distancia.
- La cercanía nunca hará que un resultado C se sitúe por delante de A1 o A2.
- Cada marcador mostrará nombre oficial, nivel de evidencia, tipo de recurso, distancia aproximada y enlace a la ficha "¿Por qué aparece?".
- Al seleccionar una tarjeta de la lista se resaltará su marcador; al seleccionar un marcador se resaltará y desplazará a su tarjeta.
- El mapa agrupará marcadores cercanos mediante clustering y mostrará el número de recursos del grupo.
- Los centros sin coordenadas válidas seguirán apareciendo en la lista, con el aviso "No disponible en el mapa", y no participarán en el cálculo de radio.
- No se enviará ni almacenará la ubicación exacta del usuario. La geolocalización será efímera y se redondeará cuando sea necesario para analítica agregada.
- El mapa no sustituirá la lista accesible ni será el único medio para comprender resultados.

63.1. Capas y controles del mapa

Control	Comportamiento	Regla de seguridad
Mi ubicación	Centra el mapa tras consentimiento	No persistir coordenadas
Municipio o población	Sustituye el origen geográfico	Conserva los demás filtros
Radio	5, 10, 20, 30, 50 km y valor configurable	No relaja la evidencia
Mover el mapa	Opción "Buscar en esta zona"	Solo ejecuta tras acción explícita
Agrupación	Cluster de marcadores próximos	Muestra cantidad, no calidad
Encajar resultados	Ajusta el encuadre al conjunto visible	Excluye centros sin coordenadas

64. EXPERIENCIA DE USUARIO ACUMULATIVA

- Paso 1: elegir uno o más perfiles o desambiguar el término ciudadano.
- Paso 2: añadir necesidades funcionales y tipos de apoyo sin perder el perfil.
- Paso 3: fijar etapa vital, red, accesibilidad y vía de acceso cuando proceda.
- Paso 4: usar ubicación del navegador o seleccionar municipio/población y radio.
- Paso 5: consultar lista y mapa sincronizados.
- Paso 6: modificar cualquier filtro y actualizar automáticamente lista, mapa, contador y URL reproducible.
- Paso 7: comparar hasta tres centros del conjunto filtrado.

64.1. Reglas de interfaz

- Mostrar siempre el resumen: "Resultados que cumplen todos estos criterios".
- Mostrar chips para filtros activos y un contador actualizado.
- No ocultar filtros aplicados dentro de paneles cerrados.
- No cambiar automáticamente AND por OR para aumentar resultados.

- Ante cero resultados, ofrecer retirar individualmente un filtro, ampliar radio o consultar orientación, sin modificar nada sin consentimiento.
- Mantener selección y posición de mapa al volver desde una ficha.
- Codificar el estado en parámetros de URL sin incluir ubicación exacta ni texto libre sensible.

65. PRUEBAS OBLIGATORIAS DE FILTROS Y MAPA

ID	Escenario	Resultado esperado
FIL-001	Añadir perfil, apoyo y etapa vital	Se aplican los tres criterios mediante AND
FIL-002	Elegir dos apoyos	Se aplica OR dentro de apoyos y se mantienen las demás dimensiones
FIL-003	Cambiar municipio	No se borran perfil, apoyo, etapa, red ni accesibilidad
FIL-004	Eliminar un chip	Solo se retira ese criterio
FIL-005	Combinación sin resultados	No relajar filtros; explicar conflicto y ofrecer acciones
GEO-003	Autorizar ubicación del navegador	Usar coordenadas solo durante la sesión
GEO-004	Denegar ubicación	Solicitar municipio o población sin bloquear el buscador
MAP-001	Lista filtrada de 12 centros con coordenadas	El mapa muestra exactamente esos 12 centros
MAP-002	Centro sin coordenadas	Aparece en lista y no en mapa ni cálculo de radio
MAP-003	Seleccionar tarjeta	Resaltar marcador correspondiente
MAP-004	Seleccionar marcador	Resaltar y enfocar tarjeta correspondiente
MAP-005	Mover mapa sin confirmar	No ejecutar una búsqueda nueva
SORT-002	C a 2 km y A2 a 30 km	A2 permanece antes que C
A11Y-003	Uso sin ratón ni mapa visual	Toda la búsqueda y resultados son operables desde lista y teclado

66. ORDEN DE EJECUCIÓN v1.4

Implementa filtros acumulativos con estado único de búsqueda. Aplica AND entre perfil, necesidad, apoyo, etapa vital, territorio, red y accesibilidad; aplica OR solo entre valores seleccionados dentro de una misma dimensión. La geolocalización del navegador será el origen predeterminado únicamente con consentimiento y podrá sustituirse por una población de la Comunidad de Madrid. Sincroniza lista y mapa: cualquier cambio actualiza ambos, conserva los demás filtros y mantiene el orden lexicográfico por evidencia antes que distancia. Los centros sin coordenadas permanecen en la lista. No relajes filtros en silencio, no almacenes ubicación exacta y garantiza una alternativa completa, accesible y operable sin mapa.

Prompt breve v1.6 (histórico, sustituido por v1.7)

Construye Madrid Apoyo Especializado con búsqueda acumulativa y mapa sincronizado. Todos los filtros deben conservarse y combinarse: AND entre dimensiones y OR entre valores de una misma dimensión. La ubicación inicial será la del navegador solo con consentimiento; también podrá elegirse una población de la Comunidad de Madrid y un radio. Cambiar la localización no borrará perfil, necesidad, apoyo, etapa vital, red ni accesibilidad. Lista y mapa mostrarán el mismo conjunto; toda selección en uno resaltará el elemento equivalente en el otro. Ordena primero por evidencia A1, A2, B1, B2 y C, y después por compatibilidad y distancia. Un centro sin coordenadas aparece en lista, pero no en mapa ni radio. Ante cero resultados, explica el conflicto y ofrece retirar filtros o ampliar radio, pero no relajes criterios automáticamente. No almacenes ubicación exacta y ofrece una experiencia completa mediante lista accesible, teclado y lector de pantalla.

67. BÚSQUEDA POR LOCALIZACIÓN Y ORIGEN PREFERIDO v1.5

La búsqueda geográfica será una dimensión acumulativa del buscador. El origen preferido será la ubicación actual del navegador, obtenida únicamente después de una acción clara y del consentimiento de la persona usuaria. La selección manual de municipio o población seguirá disponible como alternativa equivalente.

Regla principal v1.5: al abrir el buscador, ofrecer primero “Usar mi ubicación”. Si se autoriza, utilizar esa posición como origen de distancia y mapa, conservando todos los demás filtros. Si se deniega, falla o no está disponible, activar inmediatamente la búsqueda manual por municipio o población, sin bloquear la experiencia.

67.1. Modos de búsqueda por localización

Prioridad	Modo	Comportamiento	Resultado
1. Preferido	Ubicación del navegador	Solicitar permiso mediante el control “Usar mi ubicación”; obtener coordenadas efímeras y centrar lista y mapa	Resultados ordenados por evidencia y, dentro del mismo nivel, por distancia al origen
2. Alternativo	Municipio o población	Selector buscable limitado a la Comunidad de Madrid; permite	Resultados calculados desde el centroide oficial o punto de referencia

		cambiar el origen sin borrar filtros	configurado
3. Complementario	Buscar en esta zona del mapa	Usar el centro o límites del mapa solo tras acción explícita	Actualiza el área geográfica y conserva el resto de criterios
4. Recuperación	Sin localización	Permitir búsqueda no geográfica si no hay permiso ni selección manual	Lista completa filtrada; distancia indicada como no disponible

67.2. Flujo de inicio

- Al cargar el buscador, mostrar el bloque “¿Dónde buscas apoyo?” antes de los resultados, con “Usar mi ubicación” como acción primaria.
- No solicitar permisos de geolocalización automáticamente al cargar la página. La petición del navegador se inicia al pulsar “Usar mi ubicación”.
- Si la persona autoriza, mostrar una etiqueta visible como “Cerca de tu ubicación” y permitir cambiar a municipio o población.
- Si la persona deniega el permiso, mostrar directamente el selector “Elige municipio o población”, sin repetir solicitudes insistentes.
- Si la posición tarda más de 8 segundos o devuelve error, ofrecer búsqueda manual y la opción de reintentar.
- La ubicación elegida será acumulativa respecto de perfil, taxonomías, apoyos, etapa vital, red, accesibilidad y radio.
- Cambiar el origen geográfico recalcula distancia, lista y mapa, pero no reinicia ningún otro criterio.

67.3. Modelo de estado geográfico

```
location_search:
  preferred_source: browser_geolocation
  request_on_page_load: false
  request_on_user_action: true
  fallback_source: madrid_municipality_or_population
  modes: [browser, population, map_area, none]
  status: [idle, requesting, granted, denied, timeout, unavailable]
  radius_km: 20
  radius_options_km: [5, 10, 20, 30, 50]
  preserve_other_filters: true
  coordinates_storage: session_only
  include_exact_coordinates_in_url: false
  timeout_seconds: 8
```

67.4. Reglas de privacidad, precisión y accesibilidad

- No almacenar coordenadas exactas en base de datos, historial, analítica, logs ni parámetros de URL.
- Usar la ubicación únicamente durante la sesión o hasta que la persona cambie el origen.
- Mostrar distancia aproximada y evitar presentar una precisión superior a la que permita la fuente del centro.
- Explicar que la ubicación se usa para ordenar por cercanía y encuadrar el mapa, no para decidir la especialización del recurso.
- La evidencia y la coincidencia funcional prevalecen sobre la distancia.

- El selector manual debe ser operable por teclado, permitir búsqueda textual y anunciar resultados a lectores de pantalla.
- La experiencia completa debe funcionar aunque la geolocalización no esté disponible.

67.5. Pruebas de aceptación de localización

ID	Escenario	Resultado esperado
LOC-001	Entrada inicial	“Usar mi ubicación” aparece como opción principal y el selector manual como alternativa
LOC-002	Pulsar “Usar mi ubicación” y autorizar	La posición pasa a ser el origen de lista, mapa y radio
LOC-003	Denegar permiso	Se abre o destaca el selector de municipio/población sin bloquear la búsqueda
LOC-004	Tiempo de espera superior a 8 segundos	Se ofrece selección manual y reintento
LOC-005	Cambiar de ubicación a población	Se recalculan distancia y mapa; los demás filtros permanecen
LOC-006	Actualizar la página	No se exponen coordenadas exactas en la URL
LOC-007	Centro sin coordenadas	Permanece en lista con distancia no disponible y no aparece en el mapa
LOC-008	Resultado C más cercano que A2	A2 conserva prioridad; la distancia solo desempata dentro del nivel aplicable
LOC-009	Uso con teclado y lector de pantalla	Se puede seleccionar ubicación manual, radio y resultados sin operar el mapa

68. ORDEN DE EJECUCIÓN v1.5

Implementa una búsqueda acumulativa por localización cuyo dato preferido sea la ubicación del navegador. Presenta “Usar mi ubicación” como acción primaria, pero solicita el permiso únicamente después de que la persona la active. Si se concede, usa coordenadas efímeras como origen para el radio, las distancias y el mapa. Si se deniega, expira o no está disponible, muestra inmediatamente un selector buscable de municipio o población de la Comunidad de Madrid. El cambio de origen geográfico debe conservar perfil, necesidad funcional, apoyo, etapa vital, red, accesibilidad y cualquier otro filtro. Lista y mapa se actualizarán juntos. La evidencia A1, A2, B1, B2 y C prevalecerá sobre la cercanía. No almacenes

coordenadas exactas ni las incluyas en URL, logs o analítica. Garantiza una búsqueda completa sin geolocalización y sin necesidad de operar el mapa.

Prompt breve v1.6 (histórico, sustituido por v1.7)

Construye Madrid Apoyo Especializado con filtros acumulativos, búsqueda por localización y mapa sincronizado. La ubicación del navegador será el origen preferido: muestra "Usar mi ubicación" como acción principal y solicita permiso solo al pulsarla. Con consentimiento, usa la posición de forma efímera para calcular radio y distancia y centrar el mapa. Si el permiso se deniega, falla o tarda más de 8 segundos, ofrece inmediatamente un selector buscable de municipio o población de la Comunidad de Madrid. Cambiar la localización nunca borrará perfil, necesidad, apoyo, etapa vital, red ni accesibilidad. Lista y mapa mostrarán el mismo conjunto. Ordena primero por evidencia A1, A2, B1, B2 y C, y después por compatibilidad y distancia. No guardes coordenadas exactas ni las expongas en URL, logs o analítica. La experiencia debe funcionar completamente sin geolocalización y sin operar el mapa.

69. PRINCIPIOS DE DECISIÓN VERIFICABLE v1.6

La versión 1.6 refuerza el buscador como herramienta de orientación verificable. Mantiene la búsqueda acumulativa y geográfica de la v1.5, pero separa especialización, adecuación, disponibilidad, cobertura territorial y vigencia. Ningún indicador se interpretará como recomendación clínica, prescripción o garantía de plaza.

Principio v1.6: el resultado debe explicar qué está confirmado, qué no consta, qué es incompatible y qué se calcula únicamente por geografía. La cercanía no compensará una incompatibilidad ni una evidencia débil.

70. ESPECIALIZACIÓN Y ADECUACIÓN SEPARADAS

- La evidencia de especialización conserva los niveles A1, A2, B1, B2 y C.
- La adecuación mide el ajuste entre la búsqueda concreta y los atributos confirmados del servicio.
- La adecuación no utilizará puntuaciones opacas ni porcentajes que sugieran precisión clínica.
- Un recurso puede tener especialización A1 y adecuación parcial o incompatible.
- La distancia solo se utiliza después de evidencia y adecuación.

```
match_assessment:
  specialisation_evidence: A1 | A2 | B1 | B2 | C
  suitability: complete | partial | incompatible | unknown
  suitability_reasons: []
  recommendation_score: prohibited
  clinical_recommendation: prohibited
```

Adecuación	Condición	Presentación
Completa	Todos los criterios obligatorios están confirmados	Coincidencia completa
Parcial	Algún criterio preferente no consta, pero no existe incompatibilidad	Coincidencia parcial; indicar lo pendiente

Incompatible	Al menos un criterio obligatorio contradice la fuente	No mezclar con coincidencias; explicar el conflicto
Desconocida	La fuente no permite comprobar criterios esenciales	Mostrar solo como orientación y exigir confirmación

71. MATRIZ DE EXPLICACIÓN CRITERIO POR CRITERIO

- Cada ficha incluirá una matriz que reproduzca los filtros de la búsqueda y la respuesta del recurso.
- Cada fila enlazará con la fuente exacta y mostrará fecha de comprobación.
- La geografía se etiquetará como cálculo y nunca como especialización.
- “No consta” no se convertirá en “No cumple”.

Estado	Significado	Uso
Confirmado	La fuente respalda el criterio	Puede contribuir a adecuación completa
No consta	La fuente no permite verificarlo	Debe confirmarse
Incompatible	La fuente contradice el criterio	Adecuación incompatible
Calculado	Dato derivado de coordenadas o radio	Solo distancia o pertenencia al área
Pendiente de confirmar	Dato volátil o sin publicación reciente	No presentar como disponible

```
criterion_evidence:
  criterion_id: support.speech_therapy
  requested: true
  status: confirmed | not_stated | incompatible | calculated | confirm_required
  source_url: null
  source_fragment: null
  checked_at: null
  note: null
```

72. DISPONIBILIDAD Y PLAZAS

La autorización, la existencia del servicio, la pertenencia a una red y la disponibilidad de plaza son hechos distintos. Nunca se inferirá disponibilidad a partir de los tres primeros.

```
availability:
  status: available_confirmed | waiting_list | no_places | admission_closed | contact_required |
not_published
  checked_at: null
  valid_until: null
  source_url: null
```

```
  evidence_type: official_publication | centre_publication | manual_confirmation
  stale_after_days: 30
```

- Mostrar “Plaza confirmada” solo cuando exista una fuente y fecha explícitas.
- Tras 30 días sin actualización, cambiar el estado visible a “Confirmar con el centro”, salvo vigencia oficial distinta.
- No ordenar la disponibilidad desconocida como si fuera positiva.
- La lista de espera no equivale a ausencia del servicio.
- Una confirmación manual debe registrar fecha, canal y responsable de revisión, sin almacenar datos personales del solicitante.

73. VIGENCIA POR ATRIBUTO

Cada atributo conservará su propia procedencia y fecha. El centro no tendrá una única fecha global que oculte datos antiguos.

```
provenance:
  attribute: service.target_population
  value: autism
  source_url: null
  source_type: official_registry | official_directory | centre_website | manual_confirmation
  checked_at: null
  published_at: null
  status: current | review_due | stale | conflict | broken_source
```

Antigüedad o incidencia	Estado interno	Acción
0 a 90 días	Reciente	Sin acción extraordinaria
91 a 365 días	Vigente	Revisión ordinaria
Más de 365 días	Revisión prioritaria	No ocultar la fecha al ciudadano
Enlace roto	Incidencia	Revisión inmediata
Fuentes contradictorias	Conflicto	Conservar ambas evidencias y revisión humana

74. MODELO PROVEEDOR, CENTRO Y SERVICIO

- Proveedor: entidad jurídica o gestora.
- Centro: sede física o unidad asistencial con dirección propia.
- Servicio: prestación concreta ofrecida por un centro o, si procede, en domicilio o comunidad.
- Un proveedor con varias sedes generará varios centros.
- Cinco servicios en la misma sede no generarán cinco marcadores superpuestos.

```
provider:
  provider_id: stable-id
  legal_name: null
  public_name: null
```

```
centre:
  centre_id: stable-id
  provider_id: stable-id
  centre_name: null
  address: null
  coordinates: null


service:
  service_id: stable-id
  centre_id: stable-id
  service_type: null
  target_populations: []
  support_types: []
  access_routes: []
```

74.1. Identificador estable y deduplicación

- Prioridad 1: identificador oficial del registro.
- Prioridad 2: nombre normalizado y dirección completa.
- Prioridad 3: teléfono y código postal.
- Prioridad 4: coordenadas próximas y nombre similar.
- Los conflictos pasarán a revisión manual.
- Toda fusión conservará registros de origen, fuentes, fecha, motivo y reversibilidad.

```
deduplication_decision:
  candidate_ids: []
  decision: merge | keep_separate | manual_review
  rule: official_id | name_address | phone_postcode | geo_name
  decided_at: null
  reversible: true
  source_records_preserved: true
```

75. COBERTURA TERRITORIAL REAL

La ubicación física del centro y su cobertura administrativa o domiciliaria son dimensiones distintas. Estar cerca no implica admitir personas del municipio de búsqueda.

```
geographic_coverage:
  type: on_site_only | municipality | district | multiple_municipalities | community_wide |
home_service_area | not_published
  included_area_codes: []
  excluded_area_codes: []
  requires_residence: unknown
  source_url: null
  checked_at: null
```

- El radio determina proximidad, no elegibilidad territorial.
- La cobertura solo se asignará si la fuente la declara.

- Cuando no conste, mostrar “Cobertura territorial por confirmar”.
- Los servicios domiciliarios usarán su área de cobertura, no solo la dirección administrativa.

76. CORRECCIONES CIUDADANAS CONTROLADAS

Cada ficha ofrecerá “Informar de un dato incorrecto”. La aportación genera una tarea de comprobación y nunca modifica directamente el registro público.

Motivo estructurado	Tratamiento
Teléfono erróneo	Verificar con fuente oficial o centro
Centro cerrado	Prioridad alta y comprobación inmediata
Dirección incorrecta	Contrastar registro y web institucional
Servicio no prestado	Revisar servicio y fecha
Edad incorrecta	Contrastar población destinataria
Duplicado	Aplicar flujo de deduplicación
Enlace roto	Buscar sustitución oficial
Otro	Revisión manual

- No solicitar diagnóstico, informes médicos ni datos de salud.
- Recoger solo la información mínima para verificar la incidencia.
- No publicar comentarios ciudadanos.
- Registrar estado: recibida, en revisión, verificada, rechazada o aplicada.
- Mostrar al ciudadano que la corrección está pendiente de validación.

77. EVALUACIÓN CON 100 CONSULTAS CANÓNICAS

Antes de pasar a producción, mantener un conjunto versionado de al menos 100 consultas representativas. Cada consulta contendrá filtros, resultados esperados, incompatibilidades conocidas y explicación esperada.

```
canonical_query:
  id: CQ-001
  natural_language: Logopedia para menor con autismo a menos de 15 km
  filters: {}
  expected_top_entities: []
  forbidden_entities: []
  expected_explanations: []
  reviewed_at: null
  dataset_snapshot: null
```

Métrica	Umbral inicial

Precisión en los 5 primeros resultados	>= 90 %
Falsos positivos de especialización A	0
Resultados incompatibles presentados como completos	0
Explicaciones criterio por criterio correctas	100 %
Consultas sin salida útil	<= 10 %
Coordenadas exactas de usuario en logs	0

- Incluir TEA, daño cerebral adquirido, parálisis cerebral, enfermedades neurodegenerativas, apoyo laboral, atención diurna, rehabilitación, logopedia, accesibilidad y orientación.
- Incluir búsquedas con municipio, ubicación del navegador, radio, centros sin coordenadas y cobertura territorial restrictiva.
- Incluir casos sin resultados y comprobar que el sistema no relaja filtros silenciosamente.
- Repetir la batería después de cada cambio de taxonomía, extracción, ranking o deduplicación.

78. API Y ORDEN DE RESULTADOS v1.6

```
{
  "query": {},
  "total_results": 18,
  "results": [],
  "map": {"visible_results": 16, "without_coordinates": 2},
  "applied_filters": [],
  "warnings": [],
  "taxonomy_version": "1.6.0",
  "data_snapshot": "YYYY-MM-DD"
}
```

- Orden 1: excluir incompatibilidades de la lista principal.
- Orden 2: evidencia A1, A2, B1, B2 y C.
- Orden 3: adecuación completa, parcial y desconocida.
- Orden 4: disponibilidad confirmada vigente; nunca asumir disponibilidad desconocida.
- Orden 5: cobertura territorial confirmada.
- Orden 6: distancia o tiempo, únicamente como desempate dentro de condiciones equivalentes.

79. PRUEBAS DE ACEPTACIÓN v1.6

ID	Escenario	Resultado esperado
EXP-001	A1 con edad incompatible	Especialización A1 y adecuación incompatible
EXP-002	Criterio sin fuente	Estado “No consta”, no “No

		cumple”
AVL-001	Disponibilidad de hace 45 días	Mostrar “Confirmar con el centro”
AVL-002	Centro autorizado sin plazas publicadas	Disponibilidad “No publicada”
PRV-001	Teléfono reciente y servicio antiguo	Fechas separadas por atributo
DUP-001	Proveedor con tres sedes	Tres centros y tres ubicaciones
DUP-002	Sede con cinco servicios	Un marcador y cinco servicios asociados
GCV-001	Centro cercano fuera de cobertura	No mostrar como adecuación completa
COR-001	Corrección ciudadana	Crear tarea; no modificar ficha automáticamente
EVA-001	Ejecutar 100 consultas canónicas	Generar métricas y bloquear publicación si fallan umbrales
RANK-001	C cercano frente a A2 adecuado	A2 permanece delante de C
MAP-006	Dos servicios en la misma sede	Un marcador con resumen de servicios

80. ORDEN DE EJECUCIÓN v1.6

Implementa Madrid Apoyo Especializado como buscador verificable con filtros acumulativos, ubicación del navegador como origen preferido y mapa sincronizado. Separa evidencia de especialización y adecuación a la búsqueda. Para cada criterio indica: confirmado, no consta, incompatible, calculado o pendiente de confirmar, con fuente y fecha. Trata disponibilidad, cobertura territorial y vía de acceso como atributos independientes. La disponibilidad caduca a los 30 días salvo vigencia explícita. Versiona la procedencia por atributo. Modela proveedor, centro y servicio con identificadores estables y deduplicación reversible. Permite correcciones ciudadanas solo como tareas de verificación. Evalúa cada versión con al menos 100 consultas canónicas y bloquea la publicación ante falsos positivos A, resultados incompatibles presentados como completos o explicaciones incorrectas. La evidencia prevalece sobre adecuación, disponibilidad, cobertura y distancia. No emitas recomendaciones clínicas ni puntuaciones globales.

Prompt breve v1.6 (histórico, sustituido por v1.7)

Construye Madrid Apoyo Especializado con búsqueda acumulativa, ubicación del navegador como dato geográfico preferido y mapa sincronizado. Separa especialización A1/A2/B1/B2/C de adecuación completa/parcial/incompatible/desconocida. Cada ficha debe responder criterio por criterio con los

estados confirmado, no consta, incompatible, calculado o pendiente de confirmar, mostrando fuente y fecha. No confundas autorización, red pública, existencia del servicio, cobertura territorial ni disponibilidad. La disponibilidad confirmada caduca a los 30 días salvo vigencia publicada. Conserva procedencia y fecha por atributo. Modela proveedor, centro y servicio por separado, usa identificadores estables y deduplicación reversible, y muestra un solo marcador por sede. Las correcciones ciudadanas crean tareas de verificación y nunca modifican datos automáticamente. Valida cada versión con al menos 100 consultas canónicas: cero falsos positivos de especialización A, cero incompatibles presentados como coincidencias completas y 100 % de explicaciones correctas. Ordena por evidencia, adecuación, disponibilidad vigente, cobertura y finalmente distancia. No produzcas recomendaciones clínicas ni una puntuación global.

81. EVOLUCIÓN FUNCIONAL v1.7

La versión 1.7 amplía Madrid Apoyo Especializado mediante funciones que reutilizan el modelo de datos, la taxonomía, la procedencia por atributo, los filtros acumulativos, la localización geográfica y el sistema de evidencias de las versiones anteriores.

La ampliación no modificará los principios fundamentales del producto:

- No formular recomendaciones clínicas.
- No generar una puntuación global de centros.
- No rebajar silenciosamente los filtros.
- No confundir especialización, adecuación, disponibilidad, cobertura territorial y cercanía.
- No almacenar coordenadas exactas, diagnósticos, historiales clínicos ni información personal.
- No presentar como coordinados servicios ubicados en sedes diferentes, salvo evidencia explícita.
- No incorporar funciones que no puedan explicarse mediante fuentes, reglas reproducibles y datos verificables.

Principio v1.7: el buscador debe ayudar a encontrar recursos que combinen apoyos, anticipar transiciones vitales, recuperar búsquedas anteriores y conectarse con recursos educativos relacionados, sin convertir la navegación del ciudadano en un perfil personal ni mezclar ámbitos asistenciales diferentes.

81.1. Funciones activas de la v1.7

108. Búsqueda de combinaciones de apoyos en una misma sede.
109. Búsquedas guardadas localmente en el navegador.
110. Comparación «Qué ha cambiado» entre versiones del conjunto de datos.
111. Avisos de transición entre etapas vitales.
112. Puente interoperable con Madrid Educa Apoyo.
113. Preparación técnica del tiempo estimado en transporte público, sin activación productiva hasta validar las fuentes.
114. Depuración del documento maestro, sus versiones históricas y el alcance de perfiles del MVP.

81.2. Funciones excluidas de la v1.7

- Notificaciones por correo electrónico.
- Perfiles personales o cuentas de usuario.
- Almacenamiento en servidor de búsquedas o favoritos.
- Plazas en tiempo real.
- Reseñas, comentarios o valoraciones públicas.
- Ranking global de centros.
- Puntuación de idoneidad.
- Chatbot clínico.

- Predicción de disponibilidad.
- Recomendaciones clínicas o individualizadas.
- Transmisión de diagnósticos entre aplicaciones.
- Cálculo productivo de transporte público sin fuente validada.
- Integración automática con cita previa o expedientes administrativos.

82. COMBINACIÓN DE APOYOS EN UNA MISMA SEDE

El buscador permitirá solicitar varios tipos de apoyo y determinar si todos ellos están disponibles en una misma sede. Esta función utilizará la separación existente entre proveedor, centro y servicio. La coincidencia se calculará por centre_id, no únicamente por provider_id.

```
provider:
  provider_id: stable-id
centre:
  centre_id: stable-id
  provider_id: stable-id
service:
  service_id: stable-id
  centre_id: stable-id
  support_types: []
```

82.1. Modos de combinación

```
support_combination:
  mode: [any_support, all_supports_same_centre]
  requested_supports: []
```

“Cualquier apoyo” aplicará lógica OR entre apoyos. “Todos los apoyos en la misma sede” aplicará lógica AND y exigirá que todos estén vinculados al mismo centre_id.

82.2. Estados de combinación

Estado	Significado	Presentación
Todos confirmados en la misma sede	Todos los apoyos constan para el mismo centre_id	Ofrece todos los apoyos solicitados en esta sede
Combinación parcial	La sede presta parte de los apoyos	Coincidencia parcial
Mismo proveedor, sedes diferentes	Servicios de la misma entidad en centros distintos	Servicios en sedes diferentes
Red coordinada confirmada	Una fuente declara coordinación formal	Red coordinada según fuente
No confirmado	Información insuficiente	Debe confirmarse con el centro

82.3. Reglas de veracidad

115. No considerar atención integrada la mera pertenencia al mismo proveedor.
116. No considerar una sede especializada en todos los apoyos por la descripción general de la entidad.
117. Exigir procedencia por cada servicio.

118. Mostrar fecha de comprobación de cada apoyo.
119. No heredar automáticamente servicios entre sedes.
120. No utilizar proximidad geográfica como evidencia de coordinación.
121. No agrupar servicios domiciliarios con una sede salvo que la fuente establezca su vinculación.
122. No presentar una combinación parcial como resultado completo.

82.4. Explicación de la combinación

Apoyo solicitado	Estado	Sede	Fuente	Revisión
Logopedia	Confirmado	Centro A	Fuente oficial	Fecha
Terapia ocupacional	Confirmado	Centro A	Fuente oficial	Fecha
Fisioterapia	No consta	Sin confirmar	Sin fuente suficiente	Fecha

Conclusión visible: Combinación parcial: dos de los tres apoyos solicitados están confirmados en esta sede. Debe confirmarse la disponibilidad de fisioterapia.

82.5. Orden de resultados combinados

123. Todos los apoyos confirmados en la misma sede.
124. Todos los apoyos confirmados en una red coordinada.
125. Combinación parcial en la misma sede.
126. Mismo proveedor con servicios en sedes diferentes.
127. Combinación no confirmada.

Dentro de cada grupo se aplicará el orden general: evidencia, adecuación, disponibilidad vigente, cobertura territorial y distancia o tiempo validado.

83. BÚSQUEDAS GUARDADAS EN EL NAVEGADOR

Madrid Apoyo Especializado permitirá guardar búsquedas sin crear una cuenta y sin enviar sus criterios a un servidor. El almacenamiento será local mediante IndexedDB o localStorage con versionado, expiración y borrado controlado.

83.1. Datos que pueden guardarse

```
saved_search:
  saved_search_id: local-generated-id
  name: user-defined-label
  created_at: timestamp
  updated_at: timestamp
  filters:
    profiles: []
    functional_needs: []
    support_types: []
    support_combination_mode: any_support
    life_stages: []
    municipality_code: null
    population_code: null
    radius_km: null
  centre_ids: []
```

```
taxonomy_version: 1.7.0
dataset_snapshot: YYYY-MM-DD
```

83.2. Datos que no pueden guardarse

- Coordenadas exactas del navegador.
- Diagnósticos escritos en texto libre.
- Informes médicos.
- Nombre, dirección, correo o teléfono personal.
- Identificadores sanitarios o administrativos.
- Historial completo de navegación.
- Notas con datos de salud.
- Información procedente de cookies de terceros.

Si la búsqueda utilizó la ubicación del navegador, se ofrecerá guardar sin localización, guardar usando municipio o población aproximados o cancelar. Nunca se guardarán automáticamente coordenadas exactas.

83.3. Experiencia de usuario

- Guardar búsqueda.
- Asignar un nombre.
- Abrir, actualizar o duplicar búsqueda.
- Eliminar una búsqueda o todas las búsquedas locales.
- Ver qué ha cambiado.

Aviso: Esta búsqueda se guarda únicamente en este navegador. Se perderá si se borran los datos locales o se utiliza otro dispositivo.

83.4. Compatibilidad de versiones

128. Comparar taxonomy_version con la versión actual.
129. Migrar identificadores únicamente mediante reglas declaradas.
130. Informar de categorías renombradas, fusionadas, divididas o retiradas.
131. No sustituir silenciosamente un perfil por otro.
132. Solicitar revisión cuando una categoría antigua tenga varios sucesores.
133. Conservar una copia local del estado anterior hasta aceptar la migración.

84. FUNCIÓN «QUÉ HA CAMBIADO»

Una búsqueda guardada podrá compararse con un snapshot posterior mediante identificadores estables y cambios por atributo.

84.1. Cambios que deben detectarse

```
change_types:
  - centre_added
  - centre_removed
  - centre_renamed
  - service_added
  - service_removed
  - life_stage_changed
  - accessibility_changed
  - access_route_changed
  - geographic_coverage_changed
  - availability_changed
```

```
  - availability_expired
  - address_changed
  - source_updated
  - source_broken
  - evidence_level_changed
  - suitability_changed
  - merged_record
  - split_record
```

84.2. Presentación y reglas

- Agrupar en nuevos recursos, retirados, servicios incorporados, servicios que ya no constan, cambios de acceso o cobertura, información por confirmar y fuentes actualizadas o rotas.
- “Retirado del catálogo” no equivale necesariamente a “cerrado”.
- Una fuente rota se mostrará como incidencia, no como desaparición.
- Una fusión de duplicados no se mostrará como cierre.
- Toda diferencia incluirá snapshot anterior, snapshot actual y motivo.
- No habrá alertas por correo en la v1.7.

85. TRANSICIÓN ENTRE ETAPAS VITALES

El buscador incorporará avisos sobre la etapa siguiente cuando exista una transición predefinida en la taxonomía. No utilizará fecha de nacimiento, edad exacta ni perfiles personales guardados.

```
life_stage_transitions:
  early_childhood: {next: school_age, label: De atención temprana a etapa escolar}
  school_age: {next: transition_to_adulthood, label: Preparación para la vida adulta}
  minor: {next: adult, label: De servicios para menores a servicios para personas adultas}
  education: {next: training_and_employment, label: De educación a formación y empleo}
  family_child_support: {next: family_adult_support, label: Apoyo familiar en la transición a la vida
adulta}
```

85.1. Activación, presentación y seguridad

- Mostrar solo si la etapa tiene transición definida y existen recursos confirmados.
- No mostrar si depende de información personal o puede confundirse con una obligación administrativa.
- Ofrecer “Ver recursos de la etapa siguiente”, “Abrir en una búsqueda nueva”, “Comparar etapas” y “No mostrar ahora”.
- Conservar la búsqueda original.
- No inferir que la persona debe abandonar un servicio.
- No mezclar automáticamente resultados de dos etapas.
- Informar de cualquier filtro que no pueda trasladarse.

86. PUENTE CON MADRID EDUCA APOYO

Madrid Apoyo Especializado podrá enlazar con Madrid Educa Apoyo cuando la búsqueda corresponda a menores, etapa escolar, transición educativa o apoyos relacionados con el ámbito educativo. La conexión será navegación interoperable y mantendrá separados los catálogos.

86.1. Datos interoperables y prohibidos

```
education_bridge:
  source_application: madrid_apoyo_especializado
```

```
  destination_application: madrid_educa_apoyo
  transferable_filters:
    municipality_code: allowed
    district_code: allowed
    life_stage: mapped
    educational_stage: mapped
    functional_needs: mapped
    accessibility_features: mapped
    support_types: reviewed_mapping
  prohibited_data:
    exact_coordinates: true
    diagnosis_free_text: true
    personal_identity: true
    health_information: true
    browsing_history: true
```

86.2. Correspondencias y máxima especificidad

```
taxonomy_mapping:
  mapping_id: stable-id
  source_version: 1.7.0
  source_term: communication_support
  destination_term: communication_and_language_support
  relation: exact | narrower | broader | related | no_mapping
  reviewed: true
  reviewed_at: null
  warning: null
```

- Solo exact y narrower se trasladan automáticamente.
- Broader o related requieren pantalla intermedia.
- No_mapping impide transferir el filtro.
- Transferir el hijo más concreto, no padre e hijo a la vez.
- No crear equivalencias por semejanza lingüística.
- No convertir diagnósticos clínicos en necesidades educativas sin correspondencia aprobada.

86.3. Experiencia de usuario

Filtro actual	Filtro educativo resultante	Acción
Municipio de Móstoles	Móstoles	Transferir
Menor	Etapa por especificar	Elegir
Comunicación aumentativa	Apoyo a la comunicación	Transferir
Atención diurna	Sin equivalencia educativa	No transferir

Acciones: continuar a Madrid Educa Apoyo, revisar filtros, abrir sin filtros o cancelar. Los enlaces profundos solo incluirán identificadores taxonómicos y territoriales no sensibles.

87. TIEMPO EN TRANSPORTE PÚBLICO: FUNCIÓN EXPERIMENTAL

La arquitectura permitirá incorporar en el futuro tiempo estimado en transporte público. Permanecerá desactivado hasta completar una validación técnica, jurídica y documental.

```
public_transport_time:
  status: experimental_disabled
  activation_requirements:
    official_or_reusable_source: required
    compatible_licence: required
    regional_coverage: required
    update_frequency_known: required
    accessibility_information_assessed: required
    service_limits_documented: required
    reproducibility_tested: required
```

- Documentar fuente, titular, licencia, cobertura, frecuencia, horarios, festivos, incidencias, límites, coste, almacenamiento, accesibilidad, método, margen de error y fecha del cálculo.
- El valor tendrá estado calculated.
- No alterará evidencia ni compensará incompatibilidades.
- Solo se comparará con mismo origen, fecha, franja y método.
- Mientras permanezca desactivado, no se simularán ni aproximarán tiempos.

88. DEPURACIÓN DEL DOCUMENTO MAESTRO

La v1.7 será la primera versión consolidada del prompt maestro. Las instrucciones históricas permanecerán documentadas, pero no competirán con la especificación vigente.

```
product: Madrid Apoyo Especializado
prompt_version: 1.7
taxonomy_version: 1.7.0
status: current
```

88.1. Prevalencia de instrucciones

134. Orden de ejecución vigente v1.7.
135. Reglas de seguridad, privacidad y evidencia.
136. Modelo de coincidencia y adecuación v1.6.
137. Localización y búsqueda acumulativa v1.5.
138. Taxonomía vigente.
139. Requisitos técnicos no sustituidos.
140. Secciones históricas.

88.2. Alcance de perfiles del MVP

```
mvp_core_profiles:
  - autism
  - acquired_brain_injury
  - cerebral_palsy
  - neurodegenerative_diseases
experimental_profiles:
  - developmental_disorders_pending_review
  - psychosocial_or_mental_health_pending_review
```

- No describir el MVP como compuesto por seis perfiles.
- No contar perfiles experimentales como perfiles núcleo.
- No activar perfiles pendientes sin superar la puerta de aceptación.
- Mostrar el estado de cada categoría en gobernanza.

89. MODELO DE ESTADO v1.7

```
application_state:
  query:
    profiles: []
    functional_needs: []
    support_types: []
    support_combination: {mode: any_support, requested_supports: []}
    life_stages: []
  location:
    mode: browser | population | map_area | none
    radius_km: 20
    coordinates_ephemeral: true
  results:
    evidence_order: [A1, A2, B1, B2, C]
    suitability_order: [complete, partial, unknown]
    exclude_incompatible_from_primary_list: true
  saved_search:
    storage: browser_local
    exact_coordinates: prohibited
    taxonomy_version: 1.7.0
  change_detection: {enabled: true, server_notifications: false}
  life_stage_transition: {enabled: true, personal_age_storage: prohibited}
  education_bridge: {enabled: true, personal_data_transfer: prohibited, reviewed_mapping_required: true}
  public_transport: {status: experimental_disabled}
```

90. CASOS DE PRUEBA v1.7

ID	Escenario	Resultado esperado
COMB-001	Varios apoyos y “Todos en el mismo centro”	Todos confirmados para el mismo centre_id
COMB-002	Mismo proveedor, sedes distintas	Servicios en sedes diferentes
COMB-003	Un apoyo sin información	Adecuación parcial
COMB-004	Red coordinada oficial	Mostrar fuente y fecha
SAVE-001	Guardar con geolocalización	No almacenar coordenadas exactas

SAVE-003	Cambio de taxonomía	Migrar o solicitar revisión
CHG-002	Fuente rota	Incidencia, no cierre
CHG-003	Fusión de duplicados	No mostrar falso cierre
LIFE-001	Atención temprana	Ofrecer etapa escolar sin sustituir resultados
EDU-001	Menor con necesidad mapeada	Ofrecer Madrid Educa Apoyo
EDU-002	Término sin correspondencia	No transferir
TRANS-001	Transporte sin fuente validada	Función desactivada
DOC-001	Portada y cabeceras	Documento v1.7
DOC-002	Perfiles del MVP	Exactamente cuatro perfiles núcleo
DOC-003	Prompts breves	Solo v1.7 vigente
PRIV-001	Almacenamiento local	Sin coordenadas exactas ni datos personales
A11Y-004	Búsquedas guardadas con teclado	Acciones operables y anunciadas

91. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN v1.7

Criterio	Umbral
Combinaciones completas en el mismo centre_id	100 %
Falsas combinaciones por mismo proveedor	0
Coordenadas exactas almacenadas	0
Datos personales transferidos a Madrid Educa Apoyo	0
Filtros sin correspondencia revisada	0
Cambios presentados como cierres sin evidencia	0
Transiciones por edad almacenada	0
Tiempos simulados sin fuente	0
Perfiles núcleo del MVP	4

Prompts breves vigentes	1
Consultas canónicas	Al menos 100
Falsos positivos de especialización A	0
Incompatibilidades como adecuación completa	0
Explicaciones correctas	100 %
Funciones esenciales sin mapa y con teclado	100 %

92. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE 21 DÍAS v1.7

Días	Trabajo	Entregable
1-2	Depuración de versiones, cabeceras, perfiles y prompts	Documento consolidado
3-4	Modelo de combinaciones por centre_id	Esquema y consultas
5-6	Interfaz Alguno/Todos	Filtro operativo
7-8	Explicación de apoyos y sedes	Matriz de combinación
9-10	Búsquedas guardadas locales	Guardado, apertura y borrado
11-12	Comparación de snapshots	Qué ha cambiado
13	Migraciones taxonómicas	Reglas de compatibilidad
14-15	Transiciones vitales	Avisos y búsquedas derivadas
16-17	Correspondencias con Madrid Educa Apoyo	Mapeos versionados
18	Enlaces sin datos sensibles	Puente funcional
19	Privacidad, accesibilidad y seguridad	Informe de pruebas
20	Consultas canónicas	Resultados de aceptación
21	Congelación funcional	Solo correcciones críticas y documentación

92.1. Regla del día 21

- No incorporar categorías, filtros, integraciones ni funciones nuevas.
- No modificar ranking ni activar transporte público.
- No ampliar el modelo salvo corrección imprescindible.
- Resolver solo defectos críticos.
- Actualizar documentación, fijar versiones y ejecutar la batería final.

93. DEMOSTRACIÓN DE LA v1.7

Caso 1. Combinación de apoyos

Menor con autismo que necesita logopedia y terapia ocupacional en la misma sede, a menos de 20 km.

Caso 2. Búsqueda guardada

Guardar sin coordenadas exactas, reabrir, conservar filtros y borrar.

Caso 3. Qué ha cambiado

Mostrar alta, servicio que ya no consta, disponibilidad caducada, fuente rota y deduplicación.

Caso 4. Transición vital

Pasar de atención temprana a etapa escolar en una búsqueda nueva.

Caso 5. Puente educativo

Transferir solo filtros compatibles a Madrid Educa Apoyo, sin coordenadas ni datos sensibles.

94. ORDEN DE EJECUCIÓN v1.7

Implementa Madrid Apoyo Especializado como buscador ciudadano verificable de recursos sociales, sanitarios y sociosanitarios de la Comunidad de Madrid. Mantén filtros acumulativos, ubicación del navegador como origen geográfico preferido, alternativa manual por municipio o población, lista y mapa sincronizados, procedencia por atributo y separación entre especialización, adecuación, disponibilidad, cobertura territorial y distancia. Añade búsqueda de varios apoyos con los modos “alguno” y “todos en el mismo centro”; para el segundo exige el mismo centre_id. Guarda búsquedas solo en el navegador y sin coordenadas exactas ni datos personales. Añade “Qué ha cambiado” mediante snapshots e identificadores estables sin confundir incidencias o deduplicaciones con cierres. Incorpora transiciones vitales sin fecha de nacimiento y un puente con Madrid Educa Apoyo mediante correspondencias revisadas, sin transmitir datos sensibles. Mantén el transporte público desactivado hasta validar fuente, licencia y cobertura. Consolida cuatro perfiles núcleo y un único prompt breve vigente. Ordena por evidencia, adecuación, disponibilidad, cobertura y distancia. No generes puntuaciones, recomendaciones clínicas, predicciones, reseñas ni rankings. Valida con al menos 100 consultas canónicas y los umbrales de aceptación v1.7.

95. PROMPT BREVE VIGENTE v1.7

Construye Madrid Apoyo Especializado con búsqueda acumulativa, ubicación del navegador como localización preferida, alternativa por municipio o población y mapa sincronizado. Separa especialización, adecuación, disponibilidad, cobertura territorial y cercanía. Permite buscar varios

apoyos mediante “alguno” o “todos en el mismo centro”. Para considerar una combinación completa, todos los servicios deben estar confirmados para el mismo centre_id. No confundas mismo proveedor con misma sede. Guarda búsquedas solo en el navegador, sin cuenta, sin coordenadas exactas y sin datos personales o sanitarios. Compara snapshots mediante “Qué ha cambiado”, distinguiendo cambios reales, fuentes rotas y deduplicaciones. Ofrece transiciones entre etapas vitales sin almacenar fecha de nacimiento. Conecta las búsquedas de menores con Madrid Educa Apoyo mediante correspondencias taxonómicas revisadas, sin transmitir diagnósticos, identidad, historial ni ubicación exacta. Mantén el tiempo en transporte público desactivado hasta validar fuente, licencia y cobertura. Conserva cuatro perfiles núcleo del MVP y un único prompt breve vigente. Ordena por evidencia, adecuación, disponibilidad, cobertura y distancia. No generes rankings, puntuaciones globales, recomendaciones clínicas, reseñas, predicciones de plazas ni tiempos simulados.